

PEMBERDAYAAN BERBASIS MODEL PROMOSI DAN LITERASI KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KELUARGA DENGAN TB PARU

Syamilatul Khariroh
Endang Abdullah



PEMBERDAYAAN BERBASIS MODEL PROMOSI DAN LITERASI KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KELUARGA DENGAN TB PARU

Penulis:

Dr. Syamilatul Khariroh, S.Kp., M.Kes.
Endang Abdullah, S.Kp., M.Si.



Pemberdayaan Berbasis Model Promosi Dan Literasi Kesehatan Dalam Meningkatkan Kemandirian Keluarga Dengan Tb Paru

Penulis: Dr. Syamilatul Khariroh, S.Kp., M.Kes.
Endang Abdullah, S.Kp., M.Si.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7139-27-6

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kesempatan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan kajian secara empiris sehingga buku yang berjudul **"Pemberdayaan Berbasis Promosi dan Literasi Kesehatan dalam Meningkatkan Kemandirian Keluarga dengan TB Paru"**, dapat terselesaikan. Penyusunan buku ini berdasarkan hasil kajian tentang kemandirian keluarga menjalankan fungsi kesehatan keluarga dalam mencegah penularan penyakit TBC pada anggota keluarga melalui perilaku peningkatan (promosi) dan literasi kesehatan.

TBC adalah salah satu penyakit kronis yang berdampak pada kehidupan keluarga. TBC cenderung memiliki dampak sosial terhadap anggota keluarga, menyebabkan perasaan malu dan rasa bersalah dalam keluarga. Penyakit yang diderita oleh anggota keluarga dapat mengganggu komunikasi, mengubah pola aktivitas keluarga, dan mempengaruhi peran dalam keluarga. Selain itu, reaksi emosional seperti ketakutan, kebingungan, kesedihan, kekhawatiran, dan kesulitan menerima situasi baru umumnya muncul ketika keluarga pertama kali mengetahui anggota keluarga mengalami penyakit kronis, termasuk TBC.

Penyebab utama munculnya dampak social pada penyakit TBC adalah belum optimal dalam menjalankan fungsi kesehatan yang dilakukan oleh keluarga, yang disebabkan oleh rendahnya perilaku promosi dan literasi kesehatan pada keluarga. Salah satu strategi untuk meningkatkan perilaku promosi dan literasi kesehatan melalui pemberdayaan keluarga.

Penyusunan buku ini dengan pendekatan yang terintegrasi, dengan pendekatan teori perilaku kesehatan dan literasi kesehatan. Penyajian informasi dalam buku ini lebih

mudah dipahami, berbasis bukti, dan aplikatif sehingga dapat menjangkau pembaca dari berbagai latar belakang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung proses penulisan buku ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat, pakar kesehatan, dan keluarga yang memberikan inspirasi, masukan, serta motivasi. Kami juga berterima kasih kepada penerbit yang telah memberikan kepercayaan untuk menerbitkan karya ini.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat nyata dalam upaya pencegahan penyakit TBC, memperkuat perilaku promosi dan literasi kesehatan keluarga, serta meningkatkan kemandirian keluarga. Kami juga menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang.

Selamat membaca, semoga buku ini menjadi bekal yang berharga dalam menjaga kesehatan keluarga Anda.

Desember, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	----------

BAB 2 PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN KELUARGA.....	9
A. Pengertian Keluarga	9
B. Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga	11
C. Pemberdayaan Keluarga	14
D. Kemandirian Keluarga.....	24

BAB 3 MODEL PROMOSI DAN LITERASI KESEHATAN	27
A. Model Promosi Kesehatan	27
B. Model Literasi Kesehatan.....	30
C. Pengembangan Model Promosi dan Literasi Kesehatan	43

BAB 4 IMPLEMENTASI MODEL PROMOSI DAN LITERASI KESEHATAN UNTUK KEMANDIRIAN KELUARGA DENGAN TBC	49
A. Pemberdayaan Berbasis Model Promosi dan Literasi Kesehatan	49
B. Kemandirian Keluarga Dengan Masalah TBC.....	52

**BAB 5 ASUHAN KEPERAWATAN BERBASIS MODEL
PROMOSI DAN LITERASI KESEHATAN PADA
KELUARGA DENGAN TUBERCULOSIS..... 59**

- A. Asuhan Keperawatan Berbasis Model Promosi dan Literasi Kesehatan 59
- B. ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA DENGAN TBC (STUDI KASUS) 64
- C. Perawatan Pasien TB di Rumah 69

BAB 6 PROGRAM TUBERKULOSIS DI INDONESIA 79

- A. Program Pengendalian Tuberkulosis (TB) 79
- B. Eliminasi Tuberkulosis (TB) di Indonesia 81
- C. Tatalaksana Pasien TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 84
- D. Pengawas Menelan Obat (PMO)..... 88

BAB 7 PENUTUP..... 91

DAFTAR PUSTAKA..... 95

GLOSARIUM 113

PROFIL PENULIS 117

BAB 1

PENDAHULUAN

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit yang dapat dicegah dan disembuhkan, namun pada tahun 2022, TBC merupakan penyebab kematian nomor dua di dunia akibat satu agen infeksi, setelah penyakit virus corona (COVID-19), dan menyebabkan kematian hampir dua kali lipat dari HIV/AIDS, menyebabkan hampir dua kali lebih banyak kematian dibandingkan HIV/AIDS. Lebih dari 10 juta orang terus jatuh sakit karena TBC setiap tahunnya. Diperlukan tindakan segera untuk mengakhiri epidemi TBC global pada tahun 2030, merupakan tujuan yang telah diadopsi oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2023).

TBC disebabkan oleh basil *Mycobacterium tuberculosis*, yang menyebar ketika orang yang menderita TBC mengeluarkan bakteri ke udara ketika batuk. Seperempat dari populasi global diperkirakan telah terinfeksi TBC. Setelah terinfeksi, risiko terkena penyakit TBC paling tinggi dalam 2 tahun pertama (sekitar 5%), setelah itu jauh lebih rendah. Sebagian orang akan sembuh dari infeksi. Dari total jumlah orang yang terkena penyakit TBC setiap tahun, sekitar 90% adalah orang dewasa, dengan lebih banyak kasus di antara laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru (TBC paru) tetapi juga dapat menyerang bagian tubuh lainnya.

Tanpa pengobatan, tingkat kematian akibat penyakit TBC tinggi, sekitar 50%. Dengan pengobatan yang saat ini direkomendasikan oleh WHO yaitu pengobatan anti-TBC

selama 4-6 bulan, 85% penderita TBC dapat disembuhkan. Regimen 1- 6 bulan tersedia untuk mengobati infeksi TBC. Cakupan kesehatan universal (UHC) diperlukan untuk memastikan bahwa semua orang yang membutuhkan pengobatan untuk penyakit TBC atau dapat mengakses pengobatan ini. Jumlah orang yang tertular dan mengembangkan penyakit dan pada gilirannya jumlah kematian yang disebabkan oleh TBC juga dapat dikurangi melalui tindakan multisektoral untuk mengatasi TB. Faktor penentu penyakit TBC seperti kemiskinan, kekurangan gizi, infeksi HIV, merokok dan diabetes.

Berdasarkan *Global TB Report* Tahun 2023, Indonesia berada pada posisi kedua dengan jumlah beban kasus TBC terbanyak di dunia setelah India, diikuti oleh Cina. Dengan jumlah kasus TBC diperkirakan sebanyak 1.060.000 kasus TBC dan 134.000 kematian akibat TBC per tahun di Indonesia, terdapat 17 orang yang meninggal akibat TBC setiap jamnya. Sebagai upaya penanggulangan TBC, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC. Terdapat enam strategi penanggulangan TBC di Indonesia, yaitu: 1) Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC 2030; 2) Peningkatan akses layanan TBC bermutu dan berpihak pada pasien; 3) Optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC, serta pengendalian infeksi; 4) Pemanfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis, dan tatalaksana TBC; 5) Peningkatan peran serta komunitas, mitra, dan multi-sektor lainnya dalam eliminasi TBC; dan 6) Penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan.

Penguatan kapasitas dan peran komunitas dalam eliminasi TBC, merupakan salah satu strategi dalam penanggulangan TBC di Indonesia. Peran komunitas dalam penanggulangan TBC dengan membantu menyebarkan informasi dan meningkatkan pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap TBC kepada seluruh lapisan masyarakat. Pengetahuan itu antara lain seputar pencegahan, penularan, pemeriksaan, dan pengobatan TBC yang berkualitas. Meningkatkan kepedulian dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya terapi pencegahan TBC pada kontak serumah pasien TBC sebagai kelompok berisiko tinggi agar menjadi gerakan bersama, dan meningkatkan partisipasi kader, manager kasus (MK), *patient supporter* (PS), dan organisasi berbasis komunitas dalam kegiatan penemuan kasus dan pemberian terapi pencegahan TBC kepada kontak serumah dengan pasien TBC agar penularan dapat segera diputus.

Keluarga sebagai unit terkecil di komunitas merupakan salah satu sasaran yang sangat menentukan dalam penanggulangan dan pencegahan TBC di komunitas. Keluarga mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsi kesehatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan anggota keluarga dengan melaksanakan 5 (lima) tugas kesehatan keluarga. Pada keluarga dengan salah satu anggota keluarga yang menderita TBC, maka tugas kesehatan yang harus dilakukan keluarga adalah mengetahui adanya masalah TBC pada anggota keluarga dengan memahami penyakit TBC, cara penularan, mengenal tanda dan gejala penyakit TBC, serta membuat keputusan untuk mendapatkan pengobatan TBC yang tepat untuk kesembuhan pasien TBC dengan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Memberikan perawatan pada anggota keluarga dengan TBC, dengan cara pemenuhan nutrisi, keteraturan minum obat TBC

dan menjaga kebugaran tubuh dengan olah raga secara teratur. Memutuskan rantai penularan pada anggota keluarga melalui perilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker, membuang ludah pada tempatnya, tidak merokok, memperhatikan sirkulasi udara dan cahaya matahari yang ada di ruangan.

Berdasarkan survey awal tentang kemampuan keluarga menjalankan fungsi kesehatan yang dilakukan pada dua puluh (20) keluarga dengan salah satu anggota keluarga menderita TBC didapatkan data bahwa 76% keluarga belum mampu menjalankan fungsi kesehatan keluarga secara optimal. Sehingga keluarga harus mendapatkan dukungan dari komunitas dan petugas kesehatan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsi kesehatan keluarga (khariroh S, 2016).

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. PIS-PK memiliki beberapa tujuan, di antaranya: menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi balita pendek (stunting), penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular. PIS-PK menggunakan 12 indikator utama, untuk menilai status kesehatan keluarga. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, merupakan salah satu indikator dalam menentukan status kesehatan keluarga, sehingga fungsi kesehatan keluarga menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam mempertahankan dan meningkatkan status kesehatan keluarga (Kemenkes, 2016).

Pemberdayaan keluarga merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola masalah dan memanfaatkan peluang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan keluarga dapat dilakukan dengan

berbagai cara, di antaranya: meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan sumber daya keluarga; membantu keluarga mengenal potensi mereka sendiri; membimbing keluarga untuk mengembangkan potensinya; memotivasi dan memfasilitasi agar terjadi kerjasama yang harmonis; membantu menggali kontribusi semua anggota keluarga.

Pemberdayaan keluarga di bidang kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola masalah kesehatan anggota keluarga. Keluarga dengan masalah TBC merupakan keluarga yang rentan masalah kesehatan, sehingga diperlukan dukungan dan bimbingan pada keluarga untuk kemandirian keluarga dalam menjalankan fungsi kesehatan keluarga. Pemberdayaan keluarga dengan pendekatan model promosi kesehatan dan literasi kesehatan dikembangkan untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi oleh keluarga dengan masalah TBC yang menekankan pada aspek meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku keluarga melalui literasi kesehatan dan promosi kesehatan (Khariroh S, 2016).

Perubahan perilaku merupakan tujuan yang diharapkan dalam promosi kesehatan, perubahan perilaku dipengaruhi oleh berbagai factor antara lain; factor personal yang terdiri dari biologi, psikologi dan sosiokultural; perilaku sebelumnya, perilaku kognitif yang spesifik dan sikap terhadap tindakan; komitmen pasien TBC dan dukungan keluarga merupakan factor yang berpengaruh dalam perubahan perilaku pasien dan keluarga dalam program pengobatan dan pencegahan penularan TBC di keluarga.

Perubahan perilaku pasien TBC akan optimal bila didukung oleh kemampuan literasi kesehatan yaitu pengetahuan, motivasi dan kompeten untuk mengakses, memahami, menilai dan mengaplikasikan informasi kesehatan

untuk membuat penilaian dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari tentang perawatan kesehatan, pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup selama siklus hidup manusia.

Keberhasilan program penanggulangan TBC di Indonesia akan tercapai bila seluruh komponen bangsa berperan dan berkomitmen untuk segera mengakhiri epidemik tuberculosis (*The End TB*), dan didasarkan pada tiga pilar dan empat prinsip. Adapun tiga pilar dalam program *The End TB* adalah: (1) Perawatan dan pencegahan terpadu yang berpusat pada pasien: Pilar ini menempatkan pasien sebagai pusat pelayanan, dan bertujuan untuk mendeteksi dini dan mengobati orang dengan segala bentuk TB. (2) Kebijakan yang tegas dan sistem yang mendukung: Pilar ini membutuhkan partisipasi dari pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan swasta. Hal ini juga melibatkan pembuatan kebijakan sektor kesehatan dan sosial yang mendukung. (3) Penelitian dan inovasi yang intensif: Pilar ini sangat penting untuk memutus jalur epidemi TB (WHO, 2016).

Adapun prinsip-prinsip dalam penanggulangan TBC yang harus diperhatikan adalah: advokasi, kolaborasi, kesiapan dasar dan strategi akhir TB yang mencakup unsur-unsur lain: (1) Penataan layanan dan akuntabilitas pemerintah. (2) Koalisi yang kuat dengan organisasi masyarakat sipil. (3) Perlindungan dan peningkatan hak asasi manusia, etika, dan kesetaraan. (4) Adaptasi strategi dan target di tingkat nasional, dengan kolaborasi global. Strategi ini membutuhkan tindakan dari sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Penelitian dan inovasi yang intensif (pilar ketiga), mempunyai peran yang penting untuk mendukung program penanggulangan TBC. Penelitian berbasis model teori promosi

dan literasi kesehatan, merupakan salah satu inovasi dalam pencegahan penularan TBC di keluarga dengan meningkatkan kemandirian keluarga dalam menjalankan fungsi kesehatan keluarga untuk memutuskan rantai penularan pada anggota keluarga. Melalui edukasi dan supervisi pada keluarga dengan TBC diharapkan dapat meningkatkan perilaku promosi dan literasi kesehatan tentang pencegahan penyakit TBC sehingga menurunkan resiko tertular penyakit TBC di keluarga.

BAB 2

PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN KELUARGA

A. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Depkes, 2008). Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang bergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan dan mereka hidup dalam suatu rumah tangga, berintraksi satu dengan yang lain, dan dalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan (Friedman, 2010).

Keluarga dalam menjalankan fungsinya dipengaruhi oleh struktur keluarga, agar keluarga memberikan dampak terhadap individu yang menjadi anggota keluarga tersebut, maka diharapkan anggota keluarga dapat berfungsi dan berperan secara kondusif. Fungsi keluarga berfokus pada proses yang digunakan oleh keluarga untuk mencapai tujuan keluarga tersebut. Friedman, Bowden, dan Jones (2010) mengidentifikasi 5 (lima) fungsi keluarga yang paling berhubungan erat saat melakukan pengkajian atau intervensi pada keluarga, yaitu: Fungsi afektif, sosialisasi, reproduktif, ekonomi dan kesehatan keluarga.

Fungsi afektif merupakan salah satu fungsi paling vital dalam keluarga yaitu berhubungan dengan fungsi-fungsi internal keluarga perlindungan dan dukungan

psikososial para anggota keluarganya. Duvall (1977, dalam Friedman, Bowden & Jones, 2010) mengatakan kebahagiaan keluarga diukur dengan kekuatan cinta keluarga. Keluarga harus memenuhi kebutuhan afeksi atau kasih sayang dari anggotanya karena respons afektif dari seorang anggota keluarga memberikan penghargaan terhadap kehidupan keluarga.

Fungsi sosialisasi adalah proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Sosialisasi dimulai sejak lahir, fungsi ini berguna untuk membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. Fungsi sosialisasi merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup dimana individu secara kontinu mengubah perilaku mereka sebagai respon terhadap situasi yang mereka alami. Fungsi ini bertujuan untuk membuat anggota keluarga menjadi anggota masyarakat yang produktif, dan juga sebagai penganugerahan status anggota keluarga.

Fungsi reproduksi merupakan fungsi keluarga untuk menjaga kelangsungan generasi dan juga untuk keberlangsungan hidup keluarga. Fungsi ekonomi keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meliputi tersedianya sumber-sumber dari keluarga secara cukup-finansial, ruang gerak dan materi serta pengalokasian sumber-sumber tersebut yang sesuai melalui proses pengambilan keputusan (Friedman, Bowden & Jones, 2010).

Fungsi perawatan kesehatan dipenuhi oleh orang tua

dengan menyediakan pangan, papan, sandang dan perawatan kesehatan. Keluarga diwajibkan untuk berusaha agar setiap anggota keluarganya terlindung dari segala bahaya termasuk penyakit (Friedman, Bowden & Jones, 2010). Notoatmodjo (2003) menyebutkan selain fungsi perawatan kesehatan, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan dalam keluarga, yaitu faktor usia, jenis kelamin, sosial ekonomi, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, status perkawinan, budaya, bentuk keluarga, struktur keluarga, dan paritas.

Dalam menjalankan fungsi kesehatan dan perawatan, keluarga mempunyai beberapa tugas dalam pemeliharaan kesehatan keluarga adalah (1) mengenal masalah kesehatan setiap anggota keluarga, (2) mengambil keputusan untuk tindakan kesehatan yang tepat (3) memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit, (4) mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan untuk keehatan anggota keluarga, (5) mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan fasilitas kesehatan (Riasmini, 2017).

Sedangkan tugas kesehatan keluarga menurut Bailon dan Maglaya (1998) dalam Effendi & Makhfudli (2009) adalah sebagai berikut: mengenal masalah kesehatan, membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat, memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan atau menciptakan suasana rumah yang sehat, merujuk pada fasilitas kesehatan masyarakat.

B. Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) merupakan program nasional yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Pendekatan keluarga diamanatkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019. Dalam Renstra disebutkan bahwa salah satu acuan bagi arah kebijakan Kementerian Kesehatan adalah penerapan pendekatan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan (*continuum of care*). Pelayanan kesehatan harus dilakukan terhadap seluruh tahapan siklus hidup manusia (*life cycle*) sejak masih dalam kandungan, sampai lahir menjadi bayi, tumbuh menjadi anak balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa muda (usia produktif), dan akhirnya menjadi dewasa tua atau usia lanjut (Kemenkes, 2015).

Melalui pendekatan keluarga, masalah-masalah kesehatan keluarga dapat ditangani dengan pendekatan siklus hidup (*life cycle*), sehingga upaya mewujudkan keluarga Sehat menjadi titik awal terwujudnya masyarakat sehat. Keberhasilan upaya membina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di keluarga merupakan kunci bagi keberhasilan upaya menciptakan kesehatan di masyarakat.

Program pembangunan kesehatan Indonesia mengacu pada 3 (tiga) pilar program Indonesia Sehat yaitu (1) mengedepankan paradigma sehat, (2) penguatan pelayanan kesehatan dan (3) pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penerapan paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Sedangkan pelaksanaan JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan manfaat

(benefit), serta kendali mutu dan biaya. Kesemuanya itu ditujukan kepada tercapainya keluarga sehat (Depkes, 2016).

Pendekatan keluarga merupakan pengembangan dari program kunjungan rumah yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan perluasan dari upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas), yang meliputi kegiatan berikut:

1. Kunjungan keluarga untuk pendataan/pengumpulan data Profil Kesehatan Keluarga dan peremajaan (*updating*) pangkalan datanya.
2. Kunjungan keluarga dalam rangka promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif.
3. Kunjungan keluarga untuk meniadakan/lanjuti pelayanan kesehatan dalam gedung.
4. Pemanfaatan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga untuk pengorganisasian/pemberdayaan masyarakat dan manajemen Puskesmas.

Kunjungan rumah (keluarga) dilakukan secara terjadwal dan rutin, dengan memanfaatkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga (*family folder*). Dengan mengunjungi keluarga di rumahnya, akan dapat mengenali masalah - masalah kesehatan keluarga dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dihadapi keluarga secara lebih menyeluruh (holistik). Individu anggota keluarga yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan, akan termotivasi untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada dan/atau pelayanan Puskesmas. Keluarga juga dapat dimotivasi untuk memperbaiki kondisi kesehatan lingkungan dan berbagai faktor risiko lain yang selama ini merugikan kesehatannya, dengan pendampingan dari petugas kesehatan.

C. Pemberdayaan Keluarga

Pemberdayaan adalah sebuah proses sosial, mengenali, mempromosikan dan meningkatkan kemampuan individu untuk menemukan kebutuhan mereka sendiri, memecahkan masalah mereka sendiri dan memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk mengendalikan hidup mereka (Graves, 2007). Pemberdayaan keluarga adalah upaya menumbuhkan pengetahuan, ketrampilan, kesadaran, kemampuan sumber daya dalam memelihara, meningkatkan status kesehatan, mendapatkan kontrol positif dari kehidupan serta meningkatkan kualitas hidup (Notoadmodjo, 2007).

Pemberdayaan keluarga adalah suatu bentuk intervensi keperawatan yang dirancang dengan tujuan mengoptimalkan kemampuan keluarga, sehingga anggota keluarga memiliki kemampuan efektif merawat anggota keluarga dan mempertahankan kehidupan mereka (Hulme, 1999). Pemberdayaan keluarga adalah mekanisme yang memungkinkan terjadinya perubahan kemampuan keluarga sebagai dampak positif dari intervensi keperawatan yang berpusat pada keluarga dan tindakan promosi kesehatan serta kesesuaian budaya yang mempengaruhi tindakan pengobatan dan perkembangan keluarga (Beam, 2010).

Konsep pemberdayaan keluarga memiliki tiga komponen utama. Pertama bahwa semua keluarga telah memiliki kekuatan dan mampu membangun kekuatan. Kedua, kesulitan keluarga dalam memenuhi kebutuhan mereka bukan karena ketidakmampuan untuk melakukannya, melainkan sistem pendukung sosial keluarga tidak memberikan peluang keluarga untuk mencapainya. Ketiga dalam upaya pemberdayaan keluarga, anggota keluarga berupaya menerapkan ketrampilan dan kompetensi

dalam rangka terjadinya perubahan dalam keluarga. (Dunst *et al.*, 1994 dalam graves, 2007).

Tujuan utama dari proses pemberdayaan keluarga adalah membantu keluarga untuk bisa mandiri yang awalnya dibantu dan diarahkan oleh perawat komunitas. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan keluarga, perawat komunitas lebih sering atau cenderung berfokus pada masalah dan sering mengungkapkan berbagai kekurangan yang ada dalam keluarga, keadaan ini akan memberikan dampak yang tidak baik terkait hubungan terapeutik antara perawat dan keluarga.

Dalam proses pemberdayaan keluarga, selain mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam keluarga, perawat diharapkan lebih berfokus dan menitikberatkan asuhan keperawatan pada identifikasi kekuatan atau sumber daya yang ada dalam keluarga, dengan menitikberatkan pada kekuatan yang ada dalam keluarga, perawat dapat menumbuhkan aspek positif keluarga seperti kepercayaan diri, peningkatan harga diri, dan juga dapat membantu keluarga untuk merasa lebih kuat untuk melihat dan menyelesaikan masalah yang ada bahkan pada situasi yang sulit sekalipun. (Haggman *et al.*, 2010).

Pemberdayaan keluarga dalam proses keperawatan adalah lebih menekankan pada aspek positif kemampuan keluarga untuk mengenali dan mengatasi masalah yang ada dibandingkan dengan melihat ketidakmampuan keluarga dalam mengatasi masalah (Renpenning *et al.*, 2003 dalam Allender *et al.*, 2014).

Tujuan pemberdayaan keluarga bidang kesehatan menurut Notoatmodjo (2010) adalah: 1) menumbuhkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran kesehatan. Pengetahuan dan kesadaran tentang cara memelihara dan

meningkatkan kesehatan adalah awal pemberdayaan kesehatan diperoleh melalui proses belajar. Belajar adalah merupakan proses dimulai alih pengetahuan dari sumber belajar kepada subjek belajar. Kemampuan sumber daya manusia memelihara dan meningkatkan kesehatan diperoleh melalui proses belajar dari petugas kesehatan yang memberikan informasi kesehatan akan menimbulkan kesadaran terhadap kesehatan dan hasilnya adalah pengetahuan kesehatan. 2) menumbuhkan kemauan atau kehendak untuk melakukan tindakan kesehatan. Kemauan atau kehendak untuk melakukan tindakan kesehatan yaitu merupakan kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan. Kemauan dapat dilanjutkan ke tindakan tetapi mungkin juga tidak. Berlanjut atau tidaknya kemauan menjadi tindakan sangat tergantung pada beberapa faktor. Faktor yang utama yang mendukung berlanjutnya kemauan menjadi tindakan adalah sarana dan prasarana untuk mendukung tindakan. 3) keluarga mampu untuk melakukan tindakan kesehatan. Lawrence green (1980) dalam Notoatmodjo (2007) menjelaskan untuk dapat terwujudnya perilaku hidup sehat ditunjang oleh beberapa faktor: (1) faktor predisposisi, faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap keluarga terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan keluarga tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut di masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi. (2) Faktor pemungkin, faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Keluarga memerlukan sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang perilaku kesehatan. (3) Faktor penguat, faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perilaku petugas kesehatan termasuk perawat, undang- undang,

peraturan-peraturan baik dari pusat maupun dari daerah yang terkait dengan kesehatan.

Haggman *et al.*, (2010) menjelaskan tentang tujuan pemberdayaan keluarga sebagai berikut: 1) membantu keluarga untuk menerima, melewati dan mempermudah proses perubahan yang akan ditemui atau dijalani oleh keluarga. 2) membangun daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan agar mampu menjalani hidup dengan sukses tanpa kesulitan dan hambatan yang berarti. 3) meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan hidup seluruh anggota keluarga sepanjang tahap perkembangan keluarga dan siklus hidupnya. 4) menggali kapasitas atau potensi tersembunyi anggota keluarga yang berupa kepribadian, ketrampilan manajerial, dan ketrampilan kepemimpinan. 5) Membina dan mendampingi proses perubahan sampai pada tahap kemandirian dan tahapan tujuan yang dapat diterima.

Pelaksanaan pemberdayaan keluarga berpusat pada interaksi kolaboratif antara keluarga dengan tenaga kesehatan. Pemberdayaan keluarga harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal positif yang hendak dicapai oleh keluarga. Dalam penggunaan konsep pemberdayaan keluarga, perawat sebaiknya melakukan refleksi dan pengukuran kapasitas pribadi terkait sejauh mana perawat mampu untuk melakukan pemberdayaan keluarga. Tujuan dari pemberdayaan keluarga adalah memfasilitasi kapasitas atau kemampuan keluarga dalam mengenali dan menemukan masalah kesehatan keluarga, untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan dalam pemecahan masalah kesehatan, dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. (Watkins *et al.*, 2003).

Perawat komunitas dan keluarga perlu memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan keluarga yaitu: 1) pemberdayaan keluarga hendaknya tidak memberikan bantuan atau pendampingan yang bersifat *charity* yang akan menjadikan ketergantungan dan melemahkan, melainkan bantuan, pendampingan, dan atau pelatihan yang mempromosikan *self reliance* dan meningkatkan kapasitas keluarga. 2) menggunakan metode pemberdayaan yang menjadikan keluarga menjadi lebih kuat, melalui pelatihan terhadap daya tahan dan daya juang menghadapi masalah (stresor). 3) meningkatkan partisipasi yang menjadikan keluarga meningkat kapasitasnya dan mampu mengambil kontrol penuh, pengambilan keputusan penuh, dan tanggung jawab penuh untuk melakukan kegiatan.

Pemberdayaan keluarga mencakup dimensi yang luas dari kebutuhan yang bersifat biopsikososiakultural dan spiritual. Graves (2007) menjelaskan bahwa ruang lingkup pemberdayaan keluarga meliputi aspek sebagai berikut: (1) Ketahanan keluarga. Peningkatan ketahanan keluarga meliputi ketahanan fisik, sosial, dan ketahanan psikologis keluarga. Ketahanan keluarga merupakan konsep yang luas dalam kehidupan keluarga yang meliputi konsep berfungsinya keluarga, pengelolaan stres keluarga, kelentingan keluarga dan tahap perkembangan keluarga; (2) Fungsi, peran dan tugas keluarga. Peningkatan kapasitas dan potensi keluarga dalam memenuhi fungsi kesehatan keluarga, melaksanakan peran keluarga baik peran formal maupun informal, serta mampu melaksanakan tugas kesehatan keluarga sesuai tahap perkembangan keluarga; (3) Sumber daya keluarga. mengelompokkan sumber daya keluarga dalam tiga kelompok yaitu : Sumber daya manusia,

meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor, serta sumber daya waktu. Sumber daya ekonomi seperti pendapatan, kesehatan, keuntungan pekerjaan dan kredit. Sumber daya lingkungan meliputi lingkungan sosial, serta lembaga politik.

Konsep pemberdayaan mengemukakan sejak dicanangkan strategi global WHO tahun 1984 yang ditindak lanjuti dalam rencana aksi dalam piagam Ottawa pada tahun 1986. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan tentang perlunya mendorong terciptanya : (1) Kebijakan berwawasan kesehatan, (2) lingkungan yang mendukung, (3) reorientasi dalam pelayanan kesehatan, (4) ketrampilan individu, (5) gerakan masyarakat (Notoadmodjo, 2010). Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk meningkatkan kemampuan, diantaranya melalui pendayagunaan potensi keluarga dan lingkungan. (Davison, 2012).

Ada tiga syarat dalam proses pemberdayaan keluarga atau masyarakat yaitu: (1) kesadaran, kejelasan, serta pengetahuan tentang apa yang akan dilakukan; (2) pemahaman yang baik tentang keinginan berbagai pihak tentang hal-hal apa, dimana dan siapa yang akan diberdayakan; (3) adanya kemauan dan ketrampilan kelompok sasaran untuk menempuh proses pemberdayaan. Kemampuan keluarga dalam bidang kesehatan mempunyai pengertian luas. Notoadmodjo (2007) mengungkapkan mampu atau mandiri di bidang kesehatan apabila: (1) Mampu mengenali masalah kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan, kelompok harus mempunyai pengetahuan kesehatan yang baik. (2) Mampu mengatasi masalah kesehatan sendiri secara mandiri. Keluarga mandiri adalah keluarga yang mampu menggali potensi untuk mengatasi masalah kesehatan (3) Mampu memelihara dan

melindungi dari ancaman kesehatan. Keluarga diharapkan melakukan antisipasi masalah kesehatan dengan upaya pencegahan. Kemampuan meningkatkan kesehatan seluruh anggota keluarga. Tujuan pemberdayaan keluarga adalah keluarga yang mandiri atau berdaya dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Pemberdayaan merupakan proses, sedangkan kemandirian merupakan hasilnya.

Dunst *et al*/(1996) dalam Watkins (2003) mengusulkan pemberdayaan keluarga sebagai suatu intervensi keperawatan dengan menyajikan model intervensi berdasarkan tiga komponen utama pemberdayaan yang berdasarkan pengalaman ilmiah dan sintesa literatur. Komponen pertama adalah ideologi pemberdayaan, yang menjelaskan bahwa semua individu dan keluarga meyakini memiliki kekuatan dan kemampuan serta kapasitas untuk menjadi kompeten. Komponen kedua adalah partisipasi pengalaman, merupakan proses membangun kekuatan dari kelemahan yang ada secara benar, komponen ini merupakan bagian dari intervensi keluarga. Komponen ketiga hasil pemberdayaan, komponen ini terdiri dari perilaku yang diperkuat atau dipelajari, penilaian terhadap peningkatan pengawasan misalnya konsep diri dan motivasi intrinsik. Model ini mendefinisikan pemberdayaan keluarga sebagai kemampuan keluarga untuk menilai, mempengaruhi, dan mengelola situasi dengan menggunakan sumber daya keluarga.

Proses pemberdayaan memiliki tahapan yang meliputi : 1) Tahap persiapan (*Engagement*) : Pada tahap *engagement* dilakukan persiapan awal atau *entry proses* pemberdayaan yang meliputi persiapan tenaga pemberdaya, sarana serta lingkungan, Pada tahapan ini perawat melakukan pengkajian kelayakan pada daerah yang akan

dijadikan sasaran baik secara formal maupun secara informal. Akses relasi dengan tokoh masyarakat juga dilakukan pada tahap ini agar terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, sedangkan pada keluarga dilakukan bina hubungan saling percaya (BHSP). 2) Tahap Pengkajian atau *Assesment*; Pengkajian dapat dilakukan terhadap individu (tokoh masyarakat) atau kelompok-kelompok masyarakat (keluarga). Perawat komunitas melakukan identifikasi masalah mengenai kebutuhan keluarga. Keluarga selain itu tahapan dari proses pengkajian adalah mengidentifikasi sumber daya atau kekuatan keluarga, dengan menitikberatkan pada kekuatan yang ada dalam keluarga, sumber daya keluarga dapat dikaji dengan komunikasi yang baik, *memberikan reinforcement* positif kepada keluarga sehingga akan terbangun hubungan yang terapeutik antara perawat dan keluarga, Diharapkan setelah mengetahui kelebihan atau sumber daya yang dimiliki, keluarga lebih percaya diri dalam mengenal dan menyelesaikan masalah yang ada. 3) Tahap perencanaan kegiatan (*designing*); Perencanaan kegiatan dilakukan bersama keluarga. Keluarga tidak hanya dituntut untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhannya namun juga bekerjasama dengan perawat untuk menyusun tujuan yang ingin dicapai. 4) Tahap Implementasi; Tahap implementasi merupakan tahap pelaksanaan program pemberdayaan. Proses implementasi yang baik harus dilandasi kerjasama yang baik antara perawat dan masyarakat maupun antara masyarakat. Hal ini ditujukan agar proses pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang disusun. 4) Tahap evaluasi; Tahap evaluasi dilakukan sebagai proses pengawasan. Pada tahap evaluasi keluarga harus dilibatkan agar terbentuk pengawasan secara internal dan dalam rangka

memandirikan keluarga dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi diharapkan dapat memberikan umpan balik yang berguna baik perbaikan program. 5) Tahap terminasi; Pada tahap terakhir ini terjadi pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas. Hal ini dilakukan karena masyarakat telah mampu secara mandiri atau telah mencapai waktu yang ditetapkan sebelumnya. Proses terminasi tidak serta merta dilakukan secara mendadak, namun secara bertahap. Sehingga jika perawat belum bisa menyelesaikan dengan baik maka kontak dengan masyarakat tetap dilakukan namun tidak secara rutin dan akhirnya perlahan-lahan dikurangi kontrak dengan keluarga sasaran. (Riasmini *et al.*, 2017).

Pemberdayaan keluarga hendaknya dilakukan dengan memperhatikan beberapa strategi utama, diantaranya adalah:

1. Holistik; Pemberdayaan keluarga sebaiknya memperhatikan berbagai dimensi kehidupan keluarga yang meliputi fungsi keluarga, peran, dan tugas keluarga, serta memperhatikan tahap perkembangan kehidupan keluarga secara keseluruhan dengan menitikberatkan pada kekuatan atau sumber daya keluarga.
2. Sinergistik; Upaya pemberdayaan keluarga sebaiknya juga memperhatikan dan menempatkan kegiatan pemberdayaan keluarga diantara program keluarga atau program kemasyarakatan lainnya yang dilaksanakan oleh berbagai pihak baik oleh pemerintah maupun non pemerintah, agar saling mendukung, menguatkan, dan saling melengkapi.
3. Fokus pada proses perubahan; Pemberdayaan adalah sebuah proses, perlu adanya ruang dan perjalanan proses dalam perencanaan, pemberdayaan keluarga tidak

hanya terbatas pada hal-hal apa yang diberikan kepada keluarga tetapi yang paling penting adalah memastikan adanya sebuah proses perubahan di dalamnya dan proses tersebut dilalui sampai tujuan tercapai.

4. Keberlanjutan; Proses pemberdayaan keluarga juga harus memperhatikan keberlanjutan program, mengingat perubahan sosial membutuhkan waktu yang cukup lama (Sunarti, 2010).

Pemberdayaan keluarga dapat menggunakan beberapa metode. Metode yang paling sering digunakan adalah penyuluhan, konseling, dan pendampingan. Penyuluhan kesehatan adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui tehnik praktek belajar atau instruksi dengan tujuan mengubah atau mempengaruhi perilaku manusia secara individu, kelompok maupun masyarakat untuk dapat lebih mandiri dalam mencapai tujuan hidup sehat (Depkes, 2002).

Penyuluhan kesehatan adalah gabungan berbagai kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip belajar untuk mencapai suatu keadaan, dimana individu, keluarga, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan ingin hidup sehat, tahu bagaimana caranya dan melakukan apa yang bisa dilakukan, secara perseorangan maupun secara kelompok dengan meminta pertolongan (Effendy, 2000).

Pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar individu, keluarga atau masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri.

Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap, dengan panduan keterampilan interpersonal, bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar atau upaya untuk mengatasi masalah. Konseling dengan fungsi pencegahan merupakan upaya mencegah timbulnya masalah kesehatan. Dewi (2015) menjelaskan salah satu metode pendidikan kesehatan untuk mengubah perilaku adalah konseling.

Konseling yang dilakukan selama 4 kali dalam satu bulan dengan waktu setiap sesi 30-60 menit dapat meningkatkan pengetahuan cukup menjadi baik, dari sikap cukup menjadi baik, dan perilaku kurang menjadi baik. Salah satu kelebihan metode konseling ialah tercipta hubungan yang baik antara konselor-klien dan klien dapat berfokus pada masalahnya. Penyuluhan dan konseling dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui media). Sedangkan pelatihan dan pendampingan merupakan media yang lebih intensif menekankan pada perubahan atau perbaikan keterampilan.

D. Kemandirian Keluarga

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, tanpa tergantung pada orang lain (Bhatia, 2005). Kemandirian keluarga adalah kemampuan keluarga yang berorientasi pada lima fungsi keluarga yaitu :
1) mengenal masalah kesehatan anggota keluarga ;
2) mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat
3) memberikan pelayanan keperawatan pada anggota

keluarga yang sakit; 4) memodifikasi atau mempertahankan lingkungan yang menguntungkan kesehatan anggota keluarga; 5) mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dengan lembaga - lembaga kesehatan yang menunjukkan pemanfaatan dengan fasilitas kesehatan yang ada (Maglaya 2006 dalam Riasmini *et al.*, 2017).

Evaluasi tingkat kemandirian keluarga diukur dengan menggunakan indikator keluarga mandiri dalam program perawatan kesehatan masyarakat dibagi dalam 4 tingkatan yaitu:

1. keluarga mandiri tingkat I (KM I) yaitu keluarga telah mampu menerima petugas dan menerima pelayanan kesehatan sesuai rencana;
2. Keluarga mandiri tingkat II (KM II), yaitu keluarga mampu melaksanakan KM I ditambah dengan keluarga mampu menyatakan masalah secara benar keluarga mampu memanfaatkan sarana kesehatan sesuai anjuran, keluarga mampu melaksanakan perawatan sederhana sesuai anjuran;
3. keluarga mandiri III (KM III), yaitu KM II ditambah dengan perilaku keluarga yang dapat melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif ;
4. keluarga mandiri IV (KM IV), yaitu KM III ditambah dengan perilaku keluarga yang mampu melaksanakan tindakan promotif secara aktif (Depkes, 2006).

BAB 3

MODEL PROMOSI DAN LITERASI KESEHATAN

A. Model Promosi Kesehatan

Nola Pender, seorang ahli teori keperawatan, mengembangkan Model Promosi Kesehatan lebih dari 40 tahun yang lalu (Pender, 2011). Model promosi kesehatan menggambarkan interaksi manusia dengan lingkungan fisik dan interpersonal dalam berbagai dimensi. Model ini menggabungkan dua teori yaitu teori nilai pengharapan (*expectancy-value*) dan teori pembelajaran sosial (*social cognitive theory*). Model promosi kesehatan terdiri dari 3(tiga) komponen yaitu: 1) Karakteristik dan pengalaman individu; 2) Kognisi dan pengaruh perilaku tertentu; 3) Hasil dari perilaku. Model ini bertujuan untuk membantu perawat memahami faktor penentu perilaku kesehatan untuk meningkatkan kesehatan melalui konseling perilaku yang efektif.

Konsep utama dari Teori Kognitif Sosial-bahwa faktor individu, perilaku, dan lingkungan saling berinteraksi-merupakan dasar dari Model Promosi Kesehatan (Srof dan Velsor-Friedrich, 2006). Walaupun Teori Kognitif Sosial dan teori serta model perilaku kesehatan lainnya mungkin membahas beberapa konsep yang sama dalam perawatan klien, keluarga, dan masyarakat, Pender mengembangkan Model Promosi Kesehatan dengan fokus pada keperawatan. Model ini mengarahkan perawat untuk menilai 8(delapan) keyakinan ketika merencanakan perubahan perilaku dan

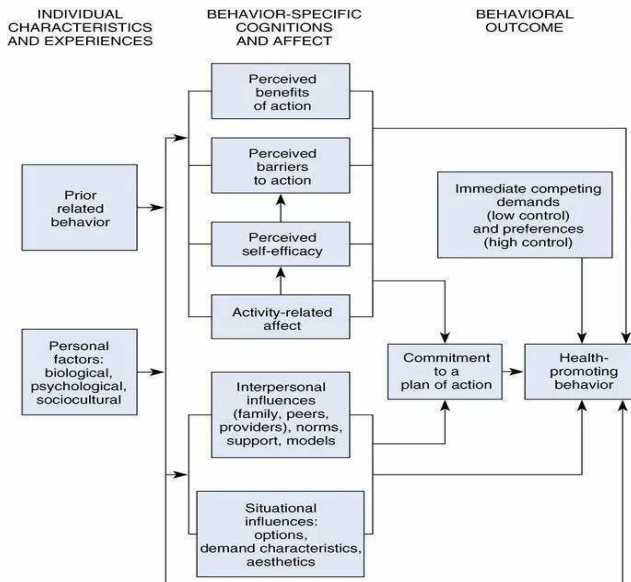
intervensi kesehatan. Pender mengembangkan manual singkat untuk Model Promosi Kesehatan, yang mencakup contoh penilaian klinis untuk memandu perawat ketika mereka bekerja dengan klien dalam promosi kesehatan dan perubahan perilaku.

Adapun 8 (delapan) keyakinan untuk melakukan perubahan perilaku pada klien berdasarkan teori promosi kesehatan (Pender, 2011) adalah:

1. Manfaat yang dirasakan dari tindakan; merupakan persepsi tentang konsekuensi positif atau penguatan dari melakukan perilaku kesehatan.
2. Hambatan yang dirasakan untuk bertindak; merupakan persepsi tentang halangan, rintangan, dan biaya pribadi dari suatu perilaku kesehatan.
3. Persepsi efikasi diri; merupakan penilaian terhadap kemampuan pribadi untuk mengatur dan melaksanakan perilaku kesehatan tertentu; kepercayaan diri dalam melakukan perilaku kesehatan dengan sukses.
4. Pengaruh yang berhubungan dengan aktivitas; merupakan kondisi subjektif atau emosi yang terjadi sebelum, selama, dan setelah melakukan perilaku kesehatan tertentu.
5. Pengaruh interpersonal (keluarga, teman sebaya, penyedia layanan); merupakan norma, panutan dukungan sosial-persepsi mengenai perilaku, kepercayaan, atau sikap orang lain yang relevan dalam hal terlibat dalam perilaku kesehatan tertentu.
6. Pengaruh situasional (pilihan, karakteristik permintaan, estetika); merupakan persepsi mengenai kesesuaian konteks kehidupan atau lingkungan dengan perilaku kesehatan tertentu.

7. Komitmen terhadap rencana tindakan; merupakan niat untuk melakukan perilaku kesehatan tertentu, termasuk identifikasi strategi khusus untuk melakukannya dengan sukses.
8. Tuntutan dan preferensi yang bersaing langsung; merupakan perilaku alternatif yang mengganggu kesadaran sebagai tindakan yang mungkin dilakukan sebelum terjadinya perilaku kesehatan yang direncanakan.

Model promosi kesehatan terdiri dari 3(tiga) komponen dan 8 (delapan) keyakinan sebagai dasar dalam perubahan perilaku individu, keluarga dan komunitas, dapat dijelaskan pada gambar 3.1 dibawah ini.



Gambar 3.1. Pender, N. (2006). *Health promotion in nursing practice*. (5th ed.). Prentice Hall: Upper Saddle River, New Jersey.

Model promosi kesehatan Pender mendefinisikan kesehatan sebagai “keadaan dinamis yang positif, bukan hanya ketiadaan penyakit.” Promosi kesehatan diarahkan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan klien. Model ini menggambarkan sifat multi-dimensi manusia saat mereka berinteraksi dalam lingkungan untuk mencapai kesehatan.

Model Promosi Kesehatan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Model Promosi Kesehatan Pender adalah salah satu model yang paling banyak digunakan untuk mengidentifikasi dan mengubah perilaku tidak sehat dan mempromosikan kesehatan. Faktor-faktor prediksi dan konstruk penjelas perilaku kesehatan dalam model Pender termasuk manfaat yang dirasakan, hambatan, dan efikasi diri; emosi perilaku; dan pengaruh interpersonal dan situasional. Berbagai konstruk tersebut telah diperkenalkan sebagai prediktor terkuat dari perilaku sehat dan perawatan diri dalam penelitian terbaru.

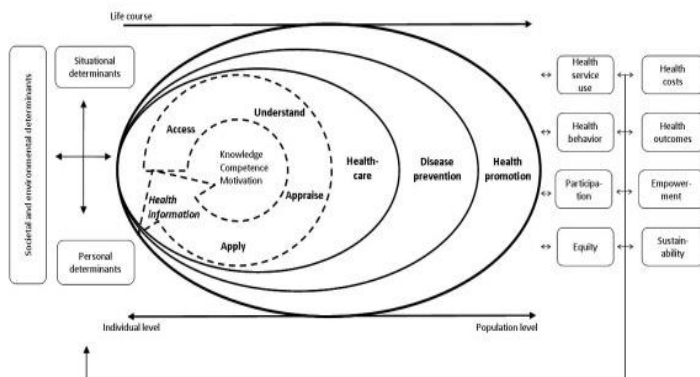
Salah satu alasan untuk menekankan penggunaan Model Promosi Kesehatan Pender adalah karena model ini mengeksplorasi, dari perspektif teoritis, faktor-faktor dan hubungan yang berkontribusi terhadap partisipasi dalam kegiatan promosi kesehatan berbasis keluarga untuk peningkatan kesehatan dan kualitas hidup individu dalam keluarga.

B. Model Literasi Kesehatan

Literasi kesehatan (*health literacy*) didefinisikan dalam beberapa cara yang berbeda sejak pertama kali diperkenalkan sebagai istilah dan konsep. Literasi kesehatan terkait dengan literasi dan pengetahuan seseorang, motivasi dan kompeten untuk mengakses, memahami, menilai dan

mengaplikasikan informasi kesehatan untuk membuat penilaian dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari tentang perawatan kesehatan, pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup sepanjang siklus hidup manusia (*The European Health Literacy Consortium*, 2012) .

Model konseptual di kembangkan oleh *The European Health Literacy Consortium* berdasarkan *The European Health Literacy Survey* yang dilakukan oleh Sorensen et.al, 2012. Model menggabungkan konseptual model yang menguraikan dimensi utama literasi kesehatan (dipresentasikan dalam bentuk oval yang kosentris), model logis menunjukkan bahwa faktor proksimal dan distal yang mempengaruhi literasi kesehatan, serta jalur yang menghubungkan literasi kesehatan dengan hasil dari kesehatan (*health outcomes*). Inti dari model menunjukkan kompetensi utama yang diperlukan untuk dipertimbangkan sebagai literasi kesehatan, yaitu kemampuan untuk: 1) *Access* (merujuk pada kemampuan untuk mencari, menemukan dan memperoleh informasi kesehatan). 2) *Understand* (merujuk pada kemampuan untuk memahami informasi kesehatan). 3) *Appraise* (menggambarkan kemampuan untuk menafsirkan, menyaring, menilai dan mengevaluasi informasi kesehatan). 4) *Apply* (merujuk pada kemampuan untuk menyampaikan dan menggunakan informasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan).



Gambar 3.2: Model Konseptual *Health Literacy*, (Sorensen et al., 2012)

Kompetensi ini dapat dengan mudah dihubungkan dengan tingkat *health literacy* secara fungsional, interaktif dan kritis. Efektifitas penggunaan empat kompetensi tersebut memungkinkan seseorang mengarahkan pada tiga domain kesehatan yang kontinum yaitu: 1) sedang mengalami sakit atau sebagai seorang pasien di tempat pelayanan kesehatan, 2) sebagai seseorang yang berisiko mengalami penyakit dalam sistem pencegahan penyakit dan 3) sebagai negara dalam kaitannya dengan peningkatan kesehatan yang berpengaruh terhadap masyarakat, tempat kerja, dan sistem pendidikan.

Kapasitas untuk melakukan tindakan yang mengarah pada kesehatan yang kontinum dipengaruhi oleh perkembangan kognitif dan psikososial serta pada pengalaman sebelumnya dan saat ini, yang berarti bahwa *health literacy* seseorang akan terus berkembang dengan pengalaman hidup.

Model menggabungkan suatu perkembangan dari individu terhadap perspektif masyarakat, seperti model mengintegrasikan konseptualisasi "medis" *health literacy*

dengan perspektif “kesehatan masyarakat” yang lebih luas. Penekanan yang lebih besar pada *health literacy* di luar dari pelayanan keperawatan mempunyai potensi yang berdampak pada pencegahan kesehatan dan mengurangi tekanan pada sistem kesehatan.

Beberapa komponen yang berpengaruh terhadap *health literacy*, pada model juga menunjukkan anteseden utama (komponen yang berpengaruh terhadap *health literacy*) dan akibat dari *health literacy*. Salah satu faktor yang mempengaruhi *health literacy*, perbedaan dibuat antara faktor yang lebih distal antara lain karakteristik personal (a.l: umur, *gender*, ras, pendidikan, status sosial ekonomi, pekerjaan, pendapatan), faktor sosial dan lingkungan fisik (a.l: situasi demografi, dukungan sosial, budaya, bahasa, tekanan politik, penggunaan media, pengaruh keluarga dan kelompok dan lingkungan fisik), faktor proksimal lebih fokus pada kompetensi personal dan bentuk lain dari literasi.

Literasi dapat di kelompokkan ke dalam:

1. *Fundamental literacy* (kompetensi dalam memahami dan menggunakan buku (*textbook*) maupun bahasa lisan yang mempengaruhi kognitif, perilaku, kemampuan dan ketrampilan sosial),
2. *Science literacy* (kemampuan untuk memahami kerumitan secara teknis, memahami teknologi secara umum dan memahami adanya ketidakpastian secara ilmiah seperti yang diharapkan),
3. *Cultural literacy* (mengakui dan menggunakan keyakinan bersama, kebiasaan, pandangan dunia dan mengidentifikasi hubungan sosial),
4. *Civic literacy* (pengetahuan tentang sumber informasi dan tentang agenda dan bagaimana menginterpretasikannya, memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam dialog

dan mengambil keputusan).

Literasi kesehatan telah didefinisikan sebagai "tingkat di mana individu memiliki kapasitas untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi dan layanan kesehatan dasar yang diperlukan untuk membuat keputusan kesehatan yang tepat" (Nielsen-Bohlman et al., 2004). Literasi kesehatan yang rendah dikaitkan dengan lebih banyak rawat inap, penggunaan perawatan darurat yang lebih besar, penurunan penggunaan layanan pencegahan, kemampuan yang lebih buruk untuk menafsirkan label dan pesan kesehatan, status kesehatan yang lebih buruk, mortalitas yang lebih tinggi, dan biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi (Berkman et al., 2011).

Literasi kesehatan fungsional melampaui kemahiran dalam membaca, menulis, dan berhitung hingga mencakup interpretasi gambar dan komunikasi lisan (Magnani et al., 2018; Ousseine 2019). Literasi kesehatan komunikatif sangat penting untuk keterampilan abstrak seperti mengevaluasi dan mempertimbangkan pertimbangan perawatan dan terlibat dalam pengambilan keputusan medis (Magnani et al., 2018; Ousseine 2019).

Literasi kesehatan yang rendah berdampak negatif pada pengelolaan penyakit secara mandiri dan perilaku kesehatan individu seperti kepatuhan terhadap pengendalian berat badan dan intervensi penghentian tembakau serta rekomendasi skrining kanker (Weiss & Smith-Simone, 2010; Bennett et al., 2009). Individu dengan literasi kesehatan yang rendah lebih mungkin mengalami penyakit lanjut, yang mengakibatkan keterlambatan diagnosis dan pengobatan serta hasil yang lebih buruk (Aljassim & Ostini, 2020).

Literasi kesehatan tidak hanya diakui sebagai sifat individu atau faktor risiko untuk hasil kesehatan yang lebih buruk, tetapi juga sebagai aset atau karakteristik yang terkait dengan keluarga, komunitas, dan organisasi yang menyediakan layanan kesehatan dan sosial (Batterham et al., 2016). Dilihat sebagai aset, literasi kesehatan menawarkan sarana untuk memberdayakan individu, keluarga dan komunitas agar dapat menjalankan kendali yang lebih besar atas kesehatan mereka (Aljassim & Ostini, 2020; Nutbeam, 2008).

Meskipun demikian, banyak individu tidak dapat memahami atau bertindak berdasarkan informasi kesehatan karena keterbatasan literasi kesehatan (Fleary & Ettienne, 2019). Survei Penilaian Literasi Orang Dewasa Nasional menemukan bahwa 36% orang dewasa AS memiliki literasi kesehatan dasar atau di bawah dasar (Magnani et al., 2018). Di AS, orang non-kulit putih lebih cenderung memiliki literasi kesehatan yang terbatas daripada orang kulit putih (Mantwill et al., 2015; Berkman et al. 2011; Kutner et al., 2006). Status sosial ekonomi yang rendah, khususnya pencapaian pendidikan yang rendah, merupakan penentu terpenting dari literasi kesehatan (Stormacq et al., 2019; Garcia-Cordina et al. 2019). Literasi kesehatan yang rendah dikaitkan dengan pendapatan dan pendidikan (von Wagner et al., 2007; Paasche-Orlow et al., 2005). Tingkat literasi kesehatan yang terbatas juga lebih tinggi di kalangan lansia dan di kalangan penutur bahasa Inggris non-asli (Berkman et al., 2011; Fleary & Ettienne, 2019).

Pengambilan keputusan bersama sering digunakan sebagai komponen utama perawatan kesehatan yang berpusat pada pasien, tetapi komunikasi pasien dan penyedia layanan yang efektif bergantung pada tingkat

literasi kesehatan. Pasien harus mampu memahami dan memproses informasi medis untuk membuat keputusan yang tepat tentang perawatan kesehatan mereka. Intervensi yang menggabungkan desain sederhana, bahasa yang mudah dipahami, dan tampilan grafis telah membuat peningkatan pengambilan keputusan bersama pada populasi yang kurang beruntung ke tingkat yang lebih besar daripada mereka yang memiliki literasi yang lebih tinggi (Durand 2014). Penelitian lain mengusulkan bahwa informasi yang dirancang dengan tepat dan kompeten secara budaya dapat berkontribusi pada pengurangan kanker dan kesenjangan kesehatan lainnya (Polaceck 2007, Hawley 2017).

Literasi kesehatan merupakan faktor penting dalam pencegahan dan pengendalian penyakit (Amalraj et al., 2009; Davis et al., 2002; Halverson et al., 2013). Orang dewasa dengan literasi kesehatan terbatas memperoleh lebih sedikit informasi dari materi pencegahan dan pengendalian penyakit, dan mungkin lebih kecil kemungkinannya untuk menjalani skrining atau berhasil mengelola penyakit mereka. Misalnya, literasi kesehatan dikaitkan dengan obesitas, pilihan makanan, dan olahraga (Magnani et al., 2018). Wanita dengan literasi kesehatan rendah juga dikaitkan dengan kemungkinan skrining mamografi yang lebih rendah; mereka juga lebih mungkin melaporkan komunikasi dokter-pasien yang lebih buruk dan tingkat penyesalan keputusan yang lebih tinggi sehubungan dengan keputusan kanker payudara mereka (Berkman et al., 2011; Durand 2020).

Literasi kesehatan yang rendah juga dikaitkan dengan kurangnya pemahaman terhadap informasi medis yang kompleks (Davis et al., 2002; Halverson et al., 2013). Pemahaman pasien terhadap penyakit, pengobatan, dan

pengambilan keputusan perawatan kesehatan mereka dapat terganggu oleh literasi kesehatan yang rendah (Halverson et al., 2013).

Literasi kesehatan dikaitkan dengan determinan kesehatan lainnya (misalnya, pendidikan, pendapatan, ukuran kesenjangan sosial berbasis wilayah, dan akses ke layanan kesehatan) yang menjadi kunci keberhasilan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang ditujukan pada kesenjangan kesehatan (Simmons et al., 2017).

Intervensi yang meningkatkan literasi kesehatan dapat memberdayakan individu dan komunitas untuk mengambil tindakan terhadap determinan sosial dan ekonomi kesehatan baik di tingkat individu, keluarga maupun komunitas. Peningkatan literasi kesehatan kemungkinan akan menghasilkan peningkatan pemanfaatan layanan pencegahan, kepatuhan medis, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan kesehatan (Fleary & Ettienne, 2018).

Intervensi yang efektif untuk meningkatkan literasi kesehatan dapat mencakup intervensi untuk meningkatkan komunikasi pasien-penyedia layanan atau untuk mengembangkan keterampilan pada orang dengan literasi rendah (Rowlands et al., 2017). Literatur yang berkembang di bidang literasi kesehatan yang sedang berkembang terus menunjukkan bahwa intervensi memang membuat perbedaan dan dapat berdampak positif pada perilaku yang pada akhirnya mengurangi beban penyakit (Miller, 2016).

Jika kemajuan yang lebih besar dan hubungan yang lebih erat terjalin dengan teori literasi kesehatan dan perubahan perilaku serta kerangka kerja teoritis, maka kemanjuran tambahan dapat dicapai (Walters et al., 2020). Dengan demikian, literasi kesehatan merupakan faktor yang

berpotensi dapat dimodifikasi yang dengannya kesenjangan dalam morbiditas dan mortalitas penyakit dapat dikurangi (Mantwill et al. 2015).

Meningkatkan tingkat literasi kesehatan dalam populasi atau membuat layanan kesehatan lebih mudah diakses oleh orang-orang dengan literasi kesehatan yang rendah dapat menawarkan cara untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar dalam hasil penyakit (Stormacq et al., 2018).

Tinjauan sistematis yang dilakukan oleh (Chauhan A, et al, 2024 dalam *Bulletin of the World Health Organization*), memberikan estimasi awal yang luas tentang tingkat literasi kesehatan pada pasien dengan tuberkulosis aktif. Terutama pada negara-negara di Kawasan Afrika, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat yang juga menanggung beban tuberkulosis yang besar, diperoleh hasil adanya hubungan yang signifikan antara literasi kesehatan dan kepatuhan terhadap pengobatan tuberkulosis. Faktor-faktor seperti pengetahuan tentang tuberkulosis, praktik perawatan diri, efikasi diri, keterlibatan pasien-penyedia layanan, pemahaman tentang informasi kesehatan, dan kemampuan penyedia layanan ditemukan mempengaruhi literasi kesehatan.

Setengah dari pasien tuberkulosis memiliki literasi kesehatan yang terbatas. Literasi kesehatan yang terbatas juga telah diamati di antara pasien yang didiagnosis dengan infeksi human immunodeficiency virus (HIV) dan diabetes (masing-masing 31,4% dan 28,3%). Yang menarik, ada hubungan dua arah antara infeksi HIV dan tuberkulosis, serta diabetes dan tuberkulosis. Hasil kajian literatur terkini menunjukkan intervensi literasi kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan perilaku, dan praktik pengelolaan diri bagi orang yang hidup dengan HIV dan diabetes.

Mengingat bukti yang mendokumentasikan keterbatasan literasi kesehatan di antara pasien komorbid tuberkulosis, intervensi literasi kesehatan yang konkret diperlukan. Lebih jauh, peningkatan literasi kesehatan dapat menjadi cara yang efektif untuk mencegah komorbiditas pada individu dengan penyakit kronis, yang menunjukkan peningkatan literasi kesehatan dapat mengurangi penularan penyakit komorbid yang umumnya terkait dengan tuberkulosis seperti diabetes dan HIV, antara lain. Dengan demikian, literasi kesehatan bermanfaat dalam setiap skenario penyakit kronis di mana pemberdayaan pasien, keterlibatan aktif dalam pengelolaan diri, perawatan diri, pencarian perawatan tepat waktu, navigasi pasien dan keterlibatan pasien, sangat penting.

Hasil *literature review* (Chauhan A, et al, 2024) mengamati bahwa individu dengan tuberkulosis aktif dan literasi kesehatan terbatas memiliki peluang 1,5 kali lebih tinggi untuk mengalami kepatuhan pengobatan yang buruk dibandingkan dengan mereka yang memiliki literasi kesehatan yang memadai. Individu dengan literasi kesehatan terbatas mungkin tidak memahami pentingnya menyelesaikan seluruh rejimen pengobatan dan risiko memperoleh resistensi obat. Oleh karena itu, kepatuhan pengobatan yang buruk berkontribusi pada hasil pengobatan yang tidak menguntungkan termasuk kegagalan, kekambuhan, kekambuhan atau kematian.

Di India, pasien tuberkulosis yang tidak patuh diperkirakan memiliki kemungkinan empat kali lebih besar untuk mendapatkan hasil pengobatan yang tidak menguntungkan (OR: 4,0; 95% CI: 2,1–7,6), Sebuah meta-analisis uji klinis mengungkapkan bahwa melewatkan lebih dari 10% dosis dikaitkan dengan peningkatan risiko enam

kali lipat dari hasil tuberkulosis yang tidak menguntungkan. Ketidakpatuhan juga telah dilaporkan sebagai faktor risiko tuberkulosis yang resistan terhadap obat. Lebih jauh, mengurangi ketidakpatuhan dapat memiliki dampak epidemiologis yang lebih besar pada kejadian tuberkulosis di negara-negara dengan beban tinggi daripada di negara-negara dengan beban rendah.

Literasi kesehatan memberdayakan pasien untuk mematuhi rencana pengobatan, mempercepat peluang hasil pengobatan yang baik. Selain itu, berbagai faktor yang berpusat pada pasien mempengaruhi kepatuhan pengobatan tuberkulosis. Pengetahuan terkait tuberkulosis dan dukungan sosial merupakan penentu utama kepatuhan pengobatan di antara pasien tuberkulosis.

Di Ethiopia, pasien dengan pengetahuan yang tidak memadai diperkirakan memiliki risiko kepatuhan pengobatan yang buruk sebesar 4,11 (95% CI: 1,57–10,75) kali lebih besar. Hasil tinjauan literature review menunjukkan bahwa individu dengan pemahaman yang kuat tentang tuberkulosis umumnya menunjukkan literasi kesehatan yang lebih baik daripada mereka yang kurang berpengetahuan. Selain itu, hasil temuan kajian literature review menunjukkan literasi kesehatan dapat berfungsi sebagai penghubung antara pengetahuan tentang tuberkulosis dan dukungan sosial.

Faktor lain yang berpusat pada pasien untuk kepatuhan pengobatan yang buruk dan diagnosis yang tepat waktu adalah akses yang tertunda ke pelayanan kesehatan dan perawatan karena stigma. Stigma yang terkait dengan tuberkulosis, yang sering kali berasal dari berbagai mitos dan misinformasi, dapat dikurangi dengan literasi kesehatan. Pemahaman yang lebih baik dapat mengurangi stigma baik

yang tersirat maupun yang tersurat, sehingga mendorong individu untuk segera mencari perawatan.

Dengan demikian, literasi kesehatan muncul sebagai faktor penting yang terkait dengan kepatuhan pengobatan dan pengetahuan terkait tuberkulosis. Satu studi menunjukkan bahwa literasi kesehatan juga memediasi penyediaan dukungan sosial, seperti bantuan keuangan, saran nutrisi, dan bantuan pengobatan, yang semuanya dapat memengaruhi hasil pengobatan.

Hasil mengamati dari literature review bahwa tingkat perawatan diri yang tinggi pada pasien tuberkulosis ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan untuk memahami informasi kesehatan. Perawatan diri bergantung pada kemampuan sistem dan penyedia layanan kesehatan untuk mengajar, serta pasien untuk mempelajari keterampilan manajemen diri yang efektif. Pengamatan dari hasil literature review menunjukkan bahwa pasien tuberkulosis sering kali kesulitan memahami informasi perawatan kesehatan, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk mengelola kondisi tersebut secara efektif.

Peneliti lain telah mencatat bahwa pengetahuan tentang tuberkulosis, pendidikan kesehatan, dan dukungan keluarga berkorelasi positif dengan tingkat manajemen diri yang tinggi. Manajemen diri pasien tuberkulosis tampaknya menjadi strategi yang berpusat pada pasien yang penting untuk meningkatkan kepatuhan dan hasil pengobatan. Klien yang berusia 60 tahun ke atas dan berstatus sosial ekonomi rendah memiliki tingkat literasi kesehatan yang lebih rendah, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan, manajemen diri, dan kepatuhan pengobatan. Status sosial ekonomi tidak secara langsung memengaruhi kesehatan; namun, literasi kesehatan bertindak sebagai mediator antara

status sosial ekonomi dan kesehatan, kualitas hidup, hasil kesehatan, dan penggunaan layanan pencegahan.

Dengan demikian, karena literasi kesehatan merupakan faktor risiko yang dapat dimodifikasi, peningkatan literasi kesehatan dapat meningkatkan kesetaraan dalam perawatan kesehatan. Temuan dari *literature review* juga menunjukkan bahwa keterlibatan pasien yang kurang baik dan keterampilan yang tidak memadai di antara penyedia layanan kesehatan berdampak pada literasi kesehatan pasien tuberkulosis.

Literasi kesehatan berkaitan erat dengan tingkat pendidikan, kecerdasan, dan kemampuan komunikasi pasien, di samping kemampuan penyedia layanan untuk menggunakan bahasa dan contoh yang sesuai secara budaya, relasional, dan situasional untuk pemahaman pasien. Oleh karena itu, pengembangan intervensi literasi kesehatan yang ditargetkan sangat penting. Ini harus multifaset, yang bertujuan untuk memberdayakan pasien, meningkatkan tingkat keterlibatan mereka dalam keputusan perawatan kesehatan, dan meningkatkan kualitas komunikasi dokter-pasien. Selain itu, memastikan bahwa intervensi tersebut dievaluasi di berbagai lingkungan perawatan kesehatan yang disesuaikan dengan manajemen tuberkulosis sangat penting.

Pengamatan dari studi kasus internasional, seperti peningkatan hasil pasien untuk hepatitis C di Mesir karena peningkatan literasi kesehatan, menunjukkan bahwa investasi strategis yang serupa dalam literasi kesehatan terkait tuberkulosis dapat menghasilkan hasil positif yang sebanding.

Hasil kajian dari literature review memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, karena kurangnya alat yang seragam untuk menilai tingkat literasi kesehatan, sehingga tidak dapat

menyatukan skor literasi kesehatan, termasuk skor domain-bijaksana, untuk memperoleh tingkat literasi kesehatan yang ada di antara pasien tuberkulosis. Kedua, karena banyak penelitian tidak melaporkan hasil tuberkulosis, sehingga tidak dapat menilai dampak literasi kesehatan pada hasil tuberkulosis seperti tingkat penyembuhan, kegagalan, kekambuhan atau kematian. Ketiga, berbagai alat literasi kesehatan yang mengukur berbagai aspek literasi kesehatan membatasi keluasan meta-analisis. Sehingga tidak dapat melakukan meta-analisis subkelompok berdasarkan demografi, komorbiditas atau resistensi obat. Akhirnya, mengingat terbatasnya jumlah penelitian yang disertakan dalam analisis literasi kesehatan dan tuberkulosis, ada potensi heterogenitas dalam temuan.

Tinjauan ini menyoroti bahwa literasi kesehatan dikaitkan dengan kepatuhan pengobatan dan pemahaman penyakit. Intervensi yang berfokus pada literasi kesehatan yang disesuaikan dengan konteks yang berbeda diperlukan untuk mendorong pemberdayaan pasien dan meningkatkan hasil kesehatan. Literasi juga dapat mengurangi kesenjangan kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pasien tuberkulosis yang memiliki informasi yang baik dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya eliminasi TBC, yang akan menguntungkan masyarakat luas.

C. Pengembangan Model Promosi dan Literasi Kesehatan

Model promosi dan literasi kesehatan dikembangkan berdasarkan kajian literature dan hasil penelitian yang berbasis pada model promosi kesehatan (Pender, 2006) dan model literasi kesehatan (Sorensen, et al, 2012). Beberapa kajian dari hasil penelitian ditemukan bahwa kemandirian individu, keluarga dan komunitas dalam menyelesaikan

masalah penyakit TBC belum optimal sehingga program pencegahan dan pengobatan TBC belum mencapai target yang diharapkan.

Salah satu strategi untuk mencapai target keberhasilan penurunan prevalensi TBC dengan pendekatan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat mempunyai potensi yang tinggi dalam penurunan prevalensi TBC di Indonesia, bila diberdayakan melalui komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan adanya dukungan dari keluarga, komunitas dan petugas kesehatan diharapkan akan terjadi peningkatan literasi kesehatan, efisiensi diri, komitmen melakukan tindakan dan perubahan perilaku menjadi mandiri.

Keluarga dipadang sebagai konteks dalam pelayanan kesehatan dan keperawatan karena bila salah satu anggota keluarga menderita penyakit TBC, maka akan berdampak pada anggota keluarga yang lain, sehingga pemutusan rantai penularan TBC paling efektif bila dilakukan pada keluarga. Dalam menjalankan fungsi kesehatan, ada 5 tugas kesehatan yang harus dilakukan oleh keluarga yaitu: mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan, melakukan perawatan, modifikasi lingkungan keluarga dan pemanfaatan fasilitas kesehatan.

Peran dan dukungan keluarga dalam mencegah dan memutuskan rantai penularan penyakit TBC sangat menentukan keberhasilan capaian target Eliminasi TBC pada tahun 2030. Salah satu peran keluarga dalam perawatan pasien TBC adalah sebagai pengawas menelan obat (PMO). Kemandirian PMO dalam melakukan perawatan pasien TBC akan meningkatkan keberhasilan program pengobatan TBC dan mencegah kasus *Drop Out* pengobatan TBC. Salah satu strategi untuk meningkatkan kemandirian PMO dengan

melakukan pemberdayaan pada PMO yang merupakan bagian dari keluarga dengan TBC.

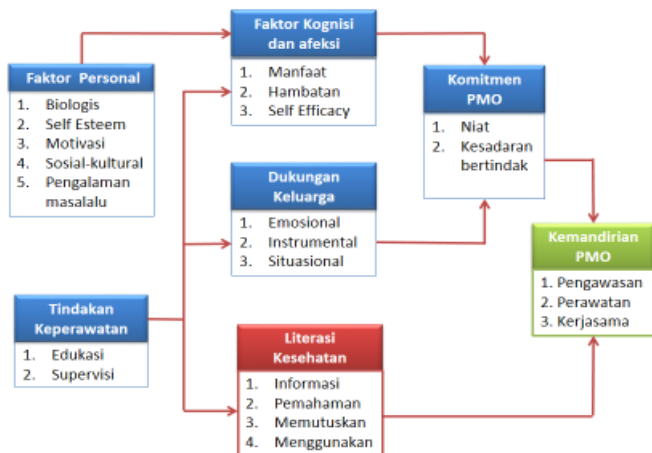
Pemberdayaan keluarga adalah mekanisme yang memungkinkan terjadinya perubahan kemampuan keluarga sebagai dampak positif dari intervensi keperawatan yang berpusat pada keluarga dan tindakan promosi kesehatan serta kesesuaian budaya yang mempengaruhi tindakan pengobatan dan perkembangan keluarga. Pemberdayaan keluarga dilakukan dalam bentuk intervensi keperawatan dengan menggunakan dasar pengembang model teori promosi dan literasi kesehatan.

Pengembangan model promosi dan literasi kesehatan dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama untuk mengembangkan model dan tahap kedua untuk uji coba model. Pengembangan model promosi dan literasi kesehatan dimulai dengan menetapkan masalah penelitian, rumusan masalah dan tujuan, menyusun kerangka teori dan kerangka konsep, menyusun instrument penelitian, menetapkan populasi dan sampel dan menguji hipotesis penelitian.

Hasil analisis model struktural dengan analisis SEM dengan LISREL tentang pemberdayaan berbasis promosi dan literasi kesehatan diperoleh hasil bahwa: analisis jalur antara variabel laten eksogen (personal dan tindakan keperawatan) dengan variabel laten endogen (kognisi, dukungan keluarga, komitmen dan kemandirian PMO) secara langsung dan tidak langsung mempunyai nilai $t > 1.96$ yang berarti signifikan.

Hasil uji ketepatan model dengan *Goodness of Fit Indices (GFI)* dengan nilai $GFI = 0.82$ dan *Comparative Fit Index (CFI)* = 0.87 yang artinya tingkat kecocokan model dapat diterima.

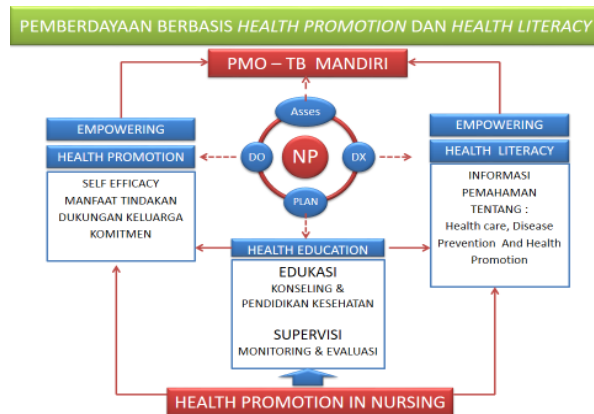
Berdasarkan hasil analisis SEM dengan LISREL dan uji hipotesis penelitian maka temuan baru pengembangan model pemberdayaan PMO berbasis *Health Promotion* dan *Health Literacy* sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 3.3: Temuan Baru Model Pemberdayaan PMO berbasis Health Promotion dan Health Literacy

Berdasarkan temuan baru model pemberdayaan PMO berbasis promosi dan literasi kesehatan dapat diketahui bahwa pemberdayaan yang dilakukan pada PMO berupa tindakan keperawatan dalam bentuk edukasi dan supervise untuk meningkatkan kognisi dan afeksi PMO dan literasi kesehatan. Adanya dukungan keluarga akan meningkatkan efikasi diri PMO sehingga menimbulkan komitmen dalam memberikan perawatan pada pasien TB. Meningkatnya Literasi kesehatan dan komitmen PMO akan berdampak pada kemandirian dalam melakukan pengawasan, perawatan dan kerjasama dengan pasien, keluarga dan petugas kesehatan.

Operasional dari model pemberdayaan PMO berbasis promosi dan literasi kesehatan dalam upaya meningkatkan kemandirian dengan pendekatan tindakan keperawatan merupakan bagian dari promosi kesehatan. Aspek yang sangat mendasar dalam promosi kesehatan adalah pemberdayaan dan pendidikan kesehatan. Pada gambar 3.4 memperlihatkan keterkaitan antara pemberdayaan, pendidikan kesehatan dan kemandirian PMO sebagai bagian dari upaya promosi kesehatan dengan pendekatan keperawatan. Tindakan keperawatan sebagai suatu proses yang berkesinambungan (pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, rencana tindakan dan evaluasi) merupakan kegiatan yang terencana dan terprogram dalam memberikan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan literasi kesehatan dengan memberikan informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang peran dan tanggungjawab sebagai PMO dan meningkatkan rasa percaya diri melalui edukasi dan supervisi.



Gambar 3.4: Pemberdayaan berbasis promosi dan literasi kesehatan dengan pendekatan proses keperawatan.

Tahap kedua dalam penelitian ini adalah uji coba model pemberdayaan berbasis promosi dan literasi kesehatan, untuk mengetahui efektifitas model dalam aplikasi di lapangan. Uji coba model diberikan pada 2(dua) kelompok PMO (kelompok perlakuan dan kelompok control). Kelompok perlakuan diberikan intervensi keperawatan berbasis promosi dan literasi kesehatan, dan kelompok control diberikan intervensi keperawatan sesuai dengan program pengobatan TBC.

Intervensi keperawatan diberikan dalam bentuk edukasi berupa pendidikan kesehatan tentang perawatan keluarga dengan TBC dan konseling, yang diberikan saat pasien TBC datang ke fasilitas pelayanan kesehatan bersama dengan pengawas menelan obat (PMO) yang berasal dari anggota keluarga. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan rumah untuk mengetahui kemampuan PMO dalam melakukan pengawasan dan perawatan pada pasien TBC. Indikator keberhasilan dari intervensi keperawatan adalah: 1) pasien teratur menelan obat; 2) terjadi konversi BTA; 3) PMO mandiri dan; 4) tidak terjadi penularan pada anggota keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan adanya perbedaan kemandirian PMO dalam memberikan perawatan pada pasien TBC. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan PMO berbasis model promosi dan literasi kesehatan efektif dalam meningkatkan kemandirian PMO dalam memberikan perawatan pada pasien TBC (Khariroh S, 2022).

BAB 4

IMPLEMENTASI MODEL PROMOSI DAN LITERASI KESEHATAN UNTUK KEMANDIRIAN KELUARGA DENGAN TBC

A. Pemberdayaan Berbasis Model Promosi dan Literasi Kesehatan

Pemberdayaan merupakan proses perubahan jangka panjang, suatu kegiatan yang dinamis yang dilakukan secara bertahap. Tahap-tahap dalam proses pemberdayaan adalah (1) membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya, (2) memperkuat potensi atau kekuatan yang dimiliki (*empowering*), (3) mempertahankan kekuatan yang ada dalam diri seseorang. Tujuan pemberdayaan adalah kemandirian dalam berfikir, bertindak dan mengendalikan yang mereka lakukan. Kemandirian adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotor dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material.

Pemberdayaan berbasis *health promotion* dan *health literacy* merupakan model pemberdayaan yang menekankan pada 2 (dua) aspek penting yaitu: 1) promosi kesehatan

(*health promotion*), merupakan upaya melakukan perubahan perilaku individu dengan menggunakan pendekatan efikasi diri (*self efficacy*), tujuan dan hasil yang diharapkan. Individu harus percaya bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa perbedaan dan hasil yang lebih baik. Individu harus mempunyai kemampuan, ketrampilan dan efikasi diri (rasa percaya diri bahwa individu akan berhasil dalam melakukan tindakan). 2) literasi kesehatan (*health literacy*), kemampuan individu untuk mendapatkan, mengolah dan memahami informasi kesehatan dasar dan layanan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan kesehatan yang tepat. Tingkatan literasi kesehatan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: fungsional literasi, interaktif literasi dan kritis literasi.

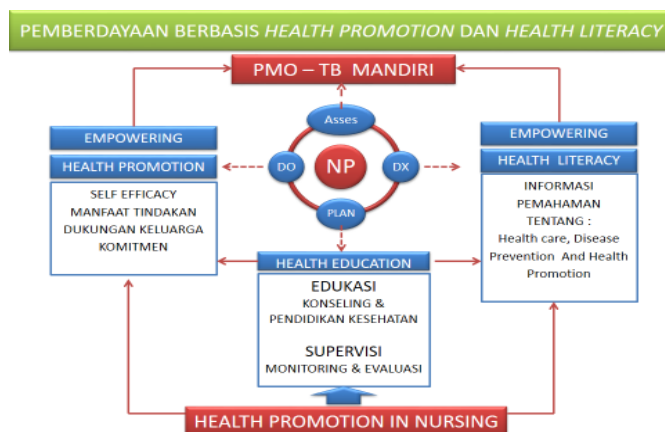
Fungsional literasi merupakan keterampilan dasar yang memadai dalam membaca dan menulis untuk dapat berfungsi secara efektif dalam situasi sehari-hari. Interaktif literasi merupakan ketrampilan dasar, kognitif dan sosial, digunakan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sehari-hari, untuk mendapatkan, mengolah dan memahami informasi yang berasal dari berbagai bentuk komunikasi dan menerapkan informasi baru untuk melakukan perubahan. Kritis literasi merupakan keterampilan kognitif dan sosial diterapkan untuk kritis menganalisis informasi dan menggunakan informasi untuk melakukan kontrol lebih besar atas peristiwa kehidupan dan perubahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan berbasis *health promotion* dan *health literacy* dilakukan melalui pendekatan peningkatan rasa percaya diri PMO bahwa tindakan yang dilakukan akan berdampak terhadap kesembuhan pasien TB dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap melalui

peningkatan literasi kesehatan, sehingga PMO mandiri melakukan pengawasan dan perawatan pada pasien TB.

Pemberdayaan PMO dilakukan dengan pendekatan keperawatan untuk meningkatkan literasi kesehatan dan efikasi diri (*self efficacy*) melalui kegiatan edukasi dan supervisi. Edukasi dapat berupa konseling dan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap sehingga terbentuk rasa percaya diri PMO, literasi kesehatan (*health literacy*) dan efikasi diri yang tinggi akan meningkatkan kemandirian PMO melakukan pengawasan dan perawatan pasien TB paru.

Pemberdayaan berbasis promosi dan literasi kesehatan untuk meningkatkan kemandirian dengan menggunakan ilustrasi gambar 5.1 dibawah ini.



Gambar 4.1: Pemberdayaan Berbasis Health promotion dan Health literacy

Implementasi model pemberdayaan berbasis promosi dan literasi kesehatan dilakukan pada PMO - pasien TBC untuk meningkatkan kemandirian, melalui edukasi tentang tugas dan tanggungjawab PMO, program pengobatan dan perawatan pasien TBC di keluarga. Edukasi

dilakukan saat pertama kali pasien TBC datang ke fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas) untuk mendapatkan pengobatan, untuk meningkatkan keberhasilan dalam program pengobatan TBC, maka setiap pasien TBC harus didampingi oleh PMO dari anggota keluarga. Panduan dalam melakukan perawatan pada pasien TBC dengan menggunakan modul.

Supervisi dilakukan oleh perawat komunitas dan keluarga untuk memantau secara langsung kemampuan PMO dalam memberikan dukungan dan pendampingan dalam program pengobatan pasien TBC serta melakukan evaluasi terhadap kemampuan keluarga dalam menjalankan tugas kesehatan keluarga dengan masalah TBC.

Edukasi dan supervise dilakukan pada keluarga dengan TBC, dapat meningkatkan kemampuan PMO dalam memahami penyakit TBC, manfaat dan hambatan dalam merawat pasien TBC dan meningkatkan efikasi diri sehingga muncul komitmen memberikan dukungan dan pendampingan pada pasien TBC untuk mencapai kesembuhan.

Konseling diberikan pada PMO, pasien TBC dan keluarga untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah dalam program pengobatan, terutama masalah keteraturan dalam menelan obat, efek samping obat dan mencegah penularan pada anggota keluarga.

B. Kemandirian Keluarga Dengan Masalah TBC

Kemandirian adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat untuk mencapai penyelesaian masalah yang dihadapi dengan menggunakan

daya atau kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotor dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material.

Kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Konatif merupakan suatu sikap perilaku seorang yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan individu. Afektif merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberhasilan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki seseorang sebagai upaya mendukung individu, keluarga dan masyarakat melakukan aktivitas pengembangan dirinya.

Self Determination Theory (SDT) atau teori penentuan nasib sendiri (Deci & Ryan, 2000), merupakan teori motivasi manusia yang telah diterapkan pada domain kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan aktifitas fisik (olah raga), adalah satu-satunya teori motivasi yang secara eksplisit mengidentifikasi kemandirian sebagai kebutuhan manusia yang dilakukan jika mendapat dukungan, memfasilitasi lebih otonomi dalam bentuk pengaturan perilaku. Penelitian tentang SDT dalam domain kesehatan berfokus pada persepsi pasien untuk kemandirian (*autonomy*) dari dukungan petugas kesehatan merupakan kebutuhan psikologis dasar sebagaimana kompetensi (*competence*) dan keterkaitan (*relatedness*).

Self Determination Theory (SDT) menyatakan bahwa sifat manusia pada dasarnya menunjukkan upaya perubahan yang positif yang dilakukan secara terus-menerus dan

berkomitmen sepanjang hidup seseorang, sebagaimana teori dasar menyatakan sebagai "kecenderungan pertumbuhan yang melekat". Individu juga memiliki kebutuhan psikologis yang bersifat mendasar (bawaan) yang merupakan dasar motivasi diri dan terintegrasi dengan kepribadian. SDT mengidentifikasi tiga kebutuhan dasar jika terpenuhi memungkinkan fungsi dan pertumbuhan yang optimal antara lain: kompetensi (*competence*), keterkaitan (*relatedness*) dan otonomi (*autonomy*). Kebutuhan ini di pandang sebagai kebutuhan universal yang mendasar (bawaan), dialami oleh manusia selama rentang hidupnya yang dipengaruhi oleh gender dan budaya.

Deci dan Vansteenkiste (2004) menyatakan bahwa ada tiga unsur penting dari teori kebutuhan dasar manusia:

1. Manusia secara inheren proaktif dengan potensi dan menguasai kekuatan batin mereka sebagai penggerak (*drive*) dan emosi.
2. Manusia memiliki kecenderungan yang melekat terhadap pertumbuhan dan fungsi terpadu.
3. Pengembangan dan tindakan yang optimal melekat pada manusia tetapi tidak terjadi secara otomatis

Self Determination Theory (SDT) mendukung tiga kebutuhan psikologis dasar yang harus dipenuhi untuk mendorong kesejahteraan dan kesehatan. Kebutuhan ini dapat diterapkan secara universal, namun beberapa mungkin lebih menonjol dari pada yang lain pada waktu tertentu dan dinyatakan secara berbeda berdasarkan waktu, budaya, atau pengalaman. Tiga kebutuhan psikologis dasar manusia antara lain:

1. Otonomi (*Autonomy*) Adalah dorongan yang bersifat universal untuk menjadi agen dalam menentukan hidup secara mandiri dan bertindak selaras dengan diri individu

yang terintegrasi. Deci dan Vansteenkiste menyatakan bahwa otonomi tidak berarti menjadi tidak tergantung dari orang lain.

2. Kompetensi (*competence*) adalah berusaha untuk meningkatkan dan mempertahankan kemampuan (*skill*) dan hasil yang dicapai.
3. Keterkaitan (*relatedness*) adalah keinginan yang bersifat universal untuk berinteraksi, keterhubungan, dan pengalaman merawat orang lain.

Prinsip SDT telah diterapkan di berbagai domain kehidupan, antara lain: bidang pekerjaan, pengasuhan, pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan teori SDT dan kebutuhan psikologi dasar manusia berupa otonomi, kompetensi dan keterkaitan maka kemandirian keluarga merupakan bentuk kebutuhan individu untuk mandiri melakukan pengawasan pada pasien TB paru selama menjalani program pengobatan TB, kompeten dalam melakukan perawatan pasien TB dan menjalin kerjasama dengan perawat, keluarga dan pasien TB.

Indikator keberhasilan pelayanan keperawatan TB di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas) meliputi indikator masukan (input) yaitu faktor personal (Pasien TB, PMO), indikator proses terdiri dari kognisi, afeksi, komitmen dan literasi kesehatan, indikator luaran (output) berupa kemandirian keluarga dan indikator dampak berupa kesembuhan pasien TB paru. Indikator output digunakan untuk menilai tingkat kemandirian keluarga yang berorientasi pada 3 (tiga) tugas atau peran sebagai keluarga dalam membantu proses kesembuhan pasien dengan penyakit TB paru yaitu:

1. Mampu melakukan tindakan pengawasan selama program pengobatan pasien TB paru.

Kemandirian (PMO-keluarga) melakukan pengawasan terdiri dari: (1) kemampuan melakukan pengawasan saat pasien menelan obat, (2) mengamati reaksi yang timbul selama program pengobatan dan melakukan rujukan kesehatan saat timbul efek samping obat, (3) memotivasi pasien TB untuk teratur dan taat menelan obat sampai selesai program pengobatan selama 6 (enam) bulan, (4) mengingatkan pasien TB untuk pemeriksaan dahak ulang pada akhir bulan ke 2 fase intensif dan akhir bulan ke 5 fase lanjutan.

2. Mampu melakukan tindakan perawatan dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif.

Kemandirian (PMO- keluarga) melakukan perawatan pasien TB terdiri dari ; (1) mengajarkan pasien TB untuk menutup mulut saat batuk, menggunakan masker selama program pengobatan dan membuang dahak atau ludah pada tempat yang telah disediakan di rumah, (2) memberikan makanan yang bergizi (makanan seimbang) untuk membantu proses kesembuhan, (3) melakukan olah raga secara teratur minimal 2 – 3 kali seminggu dengan jalan kaki pada pagi hari dan latihan bernafas yang efektif, (4) mempertahankan kondisi lingkungan rumah yang sehat, (5) menjelaskan pada seluruh anggota keluarga tentang penyakit TB, program pengobatan TB, cara pencegahan dan peningkatan kesehatan anggota keluarga.

3. Mampu membina kerjasama dengan petugas kesehatan, pasien TB dan anggota keluarga dalam melakukan pengawasan dan perawatan pasien TB paru

Kemandirian (PMO-keluarga) dalam menjalin kerjasama dengan petugas kesehatan, pasien TB dan keluarga untuk meningkatkan kesembuhan pasien TB

dengan melakukan ; (1) pemeriksaan secara dini bila timbul gejala TB (batuk lebih dari 2 minggu, demam, nafsu makan menurun, berat badan menurun dan berkeringat pada malam hari), (2) konsultasi dengan petugas kesehatan (perawat dan dokter) selama program pengobatan untuk meningkatkan status kesehatan pasien TB paru dan mencegah penularan pada anggota keluarga yang lain, (3) melibatkan anggota keluarga dalam merawat pasien TB, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan anggota keluarga.

Tingkat kemandirian (PMO - keluarga) dalam program perawatan pasien TB paru dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu: mandiri tingkat I (paling rendah) sampai mandiri tingkat III (paling tinggi).

1. Mandiri tingkat pertama (M – I)

Kriteria:

- a. Melakukan pengawasan menelan obat pada pasien TB selama program pengobatan
- b. Melakukan perawatan sederhana (makanan sehat, olah raga teratur, membuang dahak pada tempatnya, menutup mulut saat batuk, membuka jendela agar sirkulasi udara bebas)
- c. Melakukan kerjasama dengan perawat, pasien TB dan anggota keluarga dalam meningkatkan kesembuhan pasien TB

2. Mandiri tingkat dua (M – II)

Kriteria:

- a. Melakukan pengawasan menelan obat pada pasien TB selama program pengobatan
- b. Melakukan perawatan sederhana (makanan sehat, olah raga teratur, membuang dahak pada tempatnya,

- menutup mulut saat batuk, membuka jendela agar sirkulasi udara bebas)
- c. Membina dan menjalin kerjasama dengan perawat, pasien TB dan anggota keluarga dalam meningkatkan kesembuhan pasien TB
 - d. Melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif (screening TB pada anggota keluarga yang berisiko)
3. Mandiri tingkat tiga (M – III)
- Kriteria:
- a. Melakukan pengawasan menelan obat pada pasien TB selama program pengobatan
 - b. Melakukan tindakan perawatan sederhana (makanan sehat, olah raga teratur, membuang dahak pada tempatnya, menutup mulut saat batuk, membuka jendela agar sirkulasi udara bebas)
 - c. Membina dan menjalin kerjasama dengan perawat, pasien TB dan anggota keluarga dalam meningkatkan kesembuhan pasien TB
 - d. Melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif
 - e. Melaksanakan tindakan promotif secara aktif

BAB 5

ASUHAN KEPERAWATAN BERBASIS MODEL PROMOSI DAN LITERASI KESEHATAN PADA KELUARGA DENGAN TUBERCULOSIS

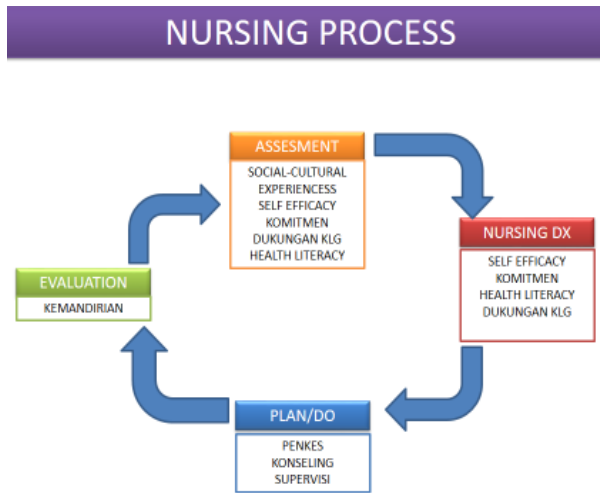
A. Asuhan Keperawatan Berbasis Model Promosi dan Literasi Kesehatan

Proses keperawatan adalah metode yang digunakan perawat untuk memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Proses ini terdiri dari lima tahap, yaitu: Pengkajian, Diagnosis, Perencanaan, Implementasi, Evaluasi. Setiap tahap dalam proses keperawatan saling terkait dan bergantung satu sama lain. Jika salah satu tahap tidak dilakukan, maka proses keperawatan tidak akan berjalan dengan baik. Proses keperawatan memiliki beberapa sifat, yaitu: Dinamis, Siklis, Interdependen, dan Fleksibel.

Proses keperawatan memiliki beberapa tujuan, yaitu: Mengidentifikasi kebutuhan perawatan kesehatan klien, Menentukan prioritas, Memberikan intervensi keperawatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan klien, Mengevaluasi keefektifan asuhan keperawatan.

Asuhan keperawatan berbasis promosi dan literasi kesehatan merupakan satu pendekatan dalam memberikan perawatan pada pasien TBC dengan pendekatan proses perawatan yang menekankan pada kajian promosi dan literasi kesehatan untuk meningkatkan kemandirian pasien TBC.

Tahapan proses keperawatan berbasis promosi dan literasi kesehatan sebagaimana gambar 4.1 dibawah ini.



Gambar 5.1: Proses Keperawatan berbasis promosi dan literasi kesehatan.

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dijelaskan bahwa proses keperawatan merupakan metode ilmiah dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Tahapan proses keperawatan berbasis promosi dan literasi kesehatan terdiri dari:

1. **Pengkajian;** Pengkajian dilakukan melalui anamnesa pada pasien TB dan PMO, sumber data pengkajian adalah PMO - TB dan atau keluarga, pengkajian meliputi: (1) Personal PMO terdiri dari : sosial kultural (norma, kepercayaan, pendapatan keluarga dan pendidikan) dan pengalaman melakukan perawatan pada anggota keluarga. (2) Kognisi dan afeksi terdiri dari : manfaat yang dirasakan dan efikasi diri (*self effikasi*) dalam melakukan pengawasan dan perawatan pasien TB paru. (3) Komitmen

rencana bertindak. (4) Dukungan keluarga. (4) Literasi kesehatan (*health literacy*) terdiri dari kemampuan mendapat informasi tentang penyakit TB, tugas dan tanggungjawab PMO dalam membantu kesembuhan pasien TB dan kemampuan memahami informasi yang diberikan oleh perawat. (6) Kemandirian PMO adalah kemampuan PMO melakukan pengawasan, perawatan dan kerjasama dengan petugas kesehatan, pasien TB dan keluarga.

2. **Masalah Keperawatan;** Masalah keperawatan dirumuskan berdasarkan hasil pengkajian. Masalah keperawatan dapat dirumuskan diantaranya: Efikasi diri rendah; Literasi kesehatan rendah, Pemahaman yang kurang tentang tugas dan tanggungjawab sebagai PMO. Belum optimal dukungan keluarga
3. **Perencanaan;** Tujuan dalam perencanaan tindakan keperawatan menjadi indikator pencapaian hasil tindakan keperawatan. Perencanaan tindakan keperawatan pada keluarga dengan TB berupa edukasi dan supervisi diantaranya: Ciptakan lingkungan yang nyaman, Tingkatkan rasa percaya diri (*self efficacy*) PMO melalui pendekatan: (1) Menunjukkan atau meniru model (PMO) yang telah berhasil melakukan peran sebagai PMO untuk membantu kesembuhan pasien TB paru, menonjolkan keberhasilan yang telah dicapai dalam membantu kesembuhan anggota keluarga yang sakit, mengurangi atau menghilangkan pengaruh buruk terhadap kegagalan dalam mencapai perilaku promosi kesehatan, melatih kemampuan sendiri (*self instructed performance*) untuk meningkatkan efikasi diri, (2) Pengalaman yang dipaparkan (*Vicarious experience*) melalui model dan simbol yang dilihat dalam meningkatkan perilaku mandiri

, (3) Persuasi verbal (*Verbal persuasion*) melalui pemberian saran, nasehat, instruksi diri, dan interpretasi pengobatan. (4) Gairah Emosional (*Emotional arousal*), melalui atribut, relaksasi, dan model berupa simbol. Perawat memfasilitasi PMO untuk mencari cara penyelesaian masalah kesehatan dalam perubahan perilaku yang terjadi dan dihadapi PMO. Pada konseling perawat membantu PMO untuk melakukan proses penyelesaian masalah dan mengambil keputusan yang tepat untuk bertindak. Konseling dapat dilakukan pada PMO, pasien TB dan keluarga yang mengalami masalah psikososial berkaitan peran dan tanggungjawab sebagai PMO, konflik dalam keluarga akibat TB, isolasi sosial akibat menderita TB, pasien yang mengalami efek samping OAT. Pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan efikasi diri (*self efficacy*) PMO melalui konseling dengan : 1) mengidentifikasi dan klarifikasi masalah yang harus diselesaikan, 2) melibatkan PMO dalam mengidentifikasi alternatif penyelesaian masalah, 3) melibatkan PMO untuk memilih alternatif penyelesaian masalah, 4) memfasilitasi PMO mengevaluasi keputusan yang diambil untuk meningkatkan kesadaran dirinya dalam mengatasi masalah. (5) Berikan edukasi untuk meningkatkan literasi kesehatan PMO terkait penyakit TB, peran dan tugas PMO, upaya pencegahan penularan TB di keluarga dan peningkatan status kesehatan pasien TB dan anggota keluarga.

4. Perawat memberikan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PMO dalam meningkatkan kemandirian melakukan pengawasan dan perawatan pasien TB. Kegiatan yang dilakukan antara lain : 1) mengkaji kebutuhan PMO :

pemahaman tentang penyakit TB, tugas dan tanggungjawab PMO, dan upaya pencegahan dan peningkatan status kesehatan pasien TB dan keluarga, 2) menyusun rencana pendidikan kesehatan, 3) memberikan pendidikan kesehatan kepada PMO, pasien TB dan keluarga dengan topik yang sesuai dengan kebutuhan, 4) mempromosikan kepada PMO, pasien TB dan keluarga cara mencegah penyakit TB dan cara pengawasan dan perawatan pasien TB melalui penyebaran leaflet dan poster, 5) membantu memilih sumber informasi antara lain: petugas kesehatan, buku bacaan tentang TB, televisi, majalah kesehatan.

5. Lakukan supervisi untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan perawatan yang dilakukan oleh PMO.
6. Optimalkan dukungan keluarga dalam membantu meningkatkan komitmen rencana bertindak dan kemandirian PMO.
7. **Implementasi Keperawatan;** Pelaksanaan tindakan keperawatan dilakukan sesuai rencana menggunakan berbagai media dan sumber yang tersedia disekitar pasien. Media pendidikan atau promosi kesehatan dapat dikembangkan oleh perawat sendiri atau memanfaatkan media yang dikembangkan oleh P2MPL subdit TB atau subdit promosi kesehatan kemenkes.
8. **Evaluasi;** Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat berupa kemandirian PMO melakukan pengawasan dan perawatan pasien TB paru. Indikator kemandirian PMO diukur dari kemandirian melakukan pengawasan, perawatan dan menjalin kerjasama dengan perawat, pasien TB dan keluarga. Dampak kemandirian

PMO berupa kesembuhan pasien TB dengan terjadi konversi sputum BTA menjadi negatif pada akhir bulan ke 2 fase intensif, tidak terjadi penularan pada anggota keluarga, peningkatan status kesehatan pasien TB paru dan deteksi dini penyakit TB pada anggota keluarga dilakukan secara aktif oleh PMO.

B. ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA DENGAN TBC (STUDI KASUS)

Studi kasus tentang asuhan keperawatan keluarga dalam konteks perawatan TBC ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan proses keperawatan melalui berbagai langkah, informasi yang diperoleh memberikan wawasan yang mendalam tentang pendekatan yang berpusat pada keluarga. Rangkuman hasil studi kasus secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang implikasi praktis dan temuan signifikan yang dihasilkan, mulai dari proses pengkajian, penentuan diagnosis, dan pelaksanaan intervensi, implementasi, dan evaluasi.

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian keperawatan pada Tn. E, berusia 58 tahun, tinggal bersama istrinya (Ny. M, 55 tahun) dan anak-anak mereka (Anak S dan Anak K). Studi kasus ini merinci hasil pengkajian bahwa Ny. M, istri Tn. E, teridentifikasi menderita TB Paru sejak Desember 2020. Gejala batuk yang terus menerus selama 3 minggu mendorong Ny. M untuk berobat ke Puskesmas. Keluarga Tn. E merupakan tipe keluarga inti, yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Tn. E merupakan keturunan Sunda, menetap di Surabaya setelah menikah, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan sedikit campuran bahasa

Sunda. Keluarga Tn. E beragama Islam dan cenderung menangani penyakit dengan membeli obat di toko setempat terlebih dahulu sebelum pergi ke Puskesmas jika kondisinya semakin parah. Saat ini, keluarga Bapak E sedang dalam tahap perkembangan keluarga dengan anak-anak yang beranjak remaja. Meskipun Ibu M memberikan kebebasan kepada anak-anaknya, namun komunikasi yang terbuka di dalam keluarga tetap diperlukan Bp E dan anak-anaknya. Rumah Bapak E berukuran 5m x 9m, terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, dan 1 dapur. Pencahayaan yang terbatas hanya terdapat di ruang tamu, dan sirkulasi udara hanya tersedia di ruang tamu.

Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pengetahuan keluarga Tn. E tentang TB masih terbatas, dan mereka menghadapi tantangan dalam merawat Ny. M yang sedang sakit. Pengamatan lebih lanjut menunjukkan masalah yang lebih kompleks. Ny. M yang masih aktif di rumah, jarang memakai masker untuk melindungi keluarga dari penularan.

Bapak E mengungkapkan bahwa Ny.M baru akan pergi ke Puskesmas ketika kondisinya memburuk. Dari hasil pemeriksaan kesehatan Ny.M, ditemukan beberapa kondisi yang memerlukan perhatian serius. Berat badan Ny.M turun drastis dari 50 Kg menjadi 43 Kg, dan gejala-gejala seperti mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan terus menerus masih ada.

2. Diagnosa Keperawatan

Hasil analisis data yang ditemukan mengidentifikasi dua masalah keperawatan yang dihadapi oleh keluarga Tn. E, yaitu Pemeliharaan Kesehatan Tidak Efektif dan Defisit Nutrisi. Kedua diagnosa tersebut dibuat

dengan mengikuti karakteristik serta tanda dan gejala yang telah ditetapkan oleh standar diagnosa keperawatan di Indonesia dan disesuaikan dengan hasil temuan dari proses pengkajian. Dari kedua diagnosa tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas masalah keperawatan keluarga berdasarkan sifat masalah, potensi perubahan masalah, kemungkinan mencegah masalah, dan tingkat kejelasan masalah (Maglaya, 2009). Setelah dilakukan perhitungan, diagnosa Pemeliharaan Kesehatan Tidak Efektif didapatkan skor (3,1/3), sedangkan diagnosa Defisit Nutrisi didapatkan skor (3). Oleh karena itu, diagnosa keperawatan utama yang ditegakkan pada keluarga Tn. E adalah Pemeliharaan Kesehatan Tidak Efektif.

3. Intervensi, Implementasi dan Evaluasi

Intervensi, implementasi, dan evaluasi didasarkan pada lima Tugas Kesehatan Keluarga, yaitu (1): mengidentifikasi masalah; (2): mengambil keputusan; (3): memberikan perawatan; (4): memodifikasi lingkungan rumah; dan (5): memanfaatkan fasilitas kesehatan. Tugas utama dalam asuhan keperawatan keluarga merupakan langkah penting untuk memastikan perawatan yang efektif dan holistik bagi anggota keluarga. Tugas-tugas ini memainkan peran penting dalam membantu keluarga mengatasi situasi kesehatan dan menjaga kesejahteraan anggota keluarga.

a. Identifikasi Masalah

Tahap ini melibatkan pengenalan dan pemahaman tentang masalah kesehatan yang dihadapi anggota keluarga. Mengidentifikasi gejala, diagnosis, dan potensi risiko kesehatan membantu keluarga mendapatkan pemahaman yang jelas tentang

kondisi kesehatan yang mereka hadapi. Upaya intervensi untuk membantu keluarga memahami masalah kesehatan yang dialami anggota keluarga yang sakit antara lain melalui Pendidikan Kesehatan terkait TB dan Pendidikan Proses Penyakit. Upaya ini meliputi langkah-langkah seperti mengidentifikasi sejauh mana keluarga siap dan mampu menerima informasi tentang TB, menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan tentang TB, menjelaskan definisi TB dan penyebabnya, menginformasikan tentang tanda dan gejala TB, menjelaskan kemungkinan komplikasi jika pengobatan TB tidak dilakukan secara teratur, mengajarkan cara mengurangi efek samping pengobatan, memberikan bimbingan perilaku hidup sehat. Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan tentang TB yang meningkat.

b. Membuat Keputusan

Membuat keputusan yang cermat mengenai pengobatan dan manajemen kondisi kesehatan adalah tanggung jawab yang sangat penting. Keluarga diharuskan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif pengobatan yang tersedia, memahami efek samping yang mungkin terjadi, dan merencanakan langkah-langkah untuk memastikan kesembuhan yang optimal. Intervensi yang diterapkan adalah melalui pelibatan keluarga. Keterlibatan keluarga memfasilitasi partisipasi anggota keluarga dalam perawatan emosional dan fisik. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain mengidentifikasi kesiapan keluarga untuk terlibat, membangun hubungan terapeutik, mendiskusikan rencana perawatan, mendukung keluarga dalam pengambilan keputusan, dan

mendorong keluarga untuk proaktif dalam perawatan. Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan dukungan keluarga dalam memenuhi kebutuhan individu.

c. Memberikan Perawatan

Tugas ini berfokus pada pelaksanaan tindakan perawatan yang sesuai dengan kondisi kesehatan anggota keluarga. Hal ini mencakup pemberian obat, terapi fisik, atau perawatan luka. Intervensi yang mendukung kepatuhan terhadap program perawatan bertujuan untuk mendukung kepatuhan terhadap program perawatan. Hal ini termasuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan, komitmen terhadap program, mengatur jadwal pendampingan, mencatat kegiatan, mendiskusikan faktor pendukung dan penghambat, melibatkan keluarga, memberikan informasi, memberikan nasihat, dan memastikan keluarga merasa didukung. Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga.

d. Memodifikasi Lingkungan Rumah

Perubahan di lingkungan rumah mendukung proses penyembuhan dan kesejahteraan anggota keluarga yang sakit. Intervensi edukasi tentang pola perilaku kebersihan bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan perilaku kebersihan diri dan lingkungan. Intervensi ini meliputi identifikasi kesiapan dan kemampuan keluarga, memantau kemampuan menjaga kebersihan, berlatih bersama, menjelaskan masalah yang mungkin terjadi, dan mengajarkan cara menjaga kebersihan. Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan perilaku kesehatan keluarga.

e. Penggunaan Fasilitas Kesehatan

Tugas ini berfokus pada pemahaman keluarga tentang pentingnya kolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan dan pelaksanaan prosedur medis. Intervensi pengenalan fasilitas perawatan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan layanan. Ini termasuk mengidentifikasi pengetahuan, menjelaskan peraturan pelayanan. Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan status kesehatan keluarga.

Kelima tugas ini saling berkaitan dan berkontribusi dalam membentuk pendekatan komprehensif untuk asuhan keperawatan keluarga. Dengan memahami dan melaksanakan tugas-tugas ini, keluarga dapat memberikan perawatan terbaik bagi anggota keluarga yang membutuhkan dan mengoptimalkan kesejahteraan dan pemulihan anggota keluarga.

C. Perawatan Pasien TB di Rumah

Keberhasilan dalam program penurunan prevalensi TB adalah adanya komitmen keluarga dalam melaksanakan fungsi kesehatan keluarga, dengan melaksanakan 5 (lima) tugas keluarga. Perawatan pasien TB di Rumah, sangat menentukan keberhasilan dalam kesembuhan dan pencegahan penularan. Upaya yang dilakukan keluarga untuk memberikan perawatan pada pasien TB sesuai dengan gejala yang muncul pada pasien TB sebagaimana dibawa ini.

1. Batuk

Batuk merupakan suatu usaha tubuh untuk membantu mengeluarkan dahak dan benda-benda asing dari batang tenggorokan dan paru-paru, jika batuk terjadi terus menerus membuat pasien menjadi lelah dan sulit

bernapas, berarti bahwa pasien mempunyai suatu gangguan atau penyakit.

Upaya yang dapat dilakukan keluarga untuk mengurangi batuk adalah:

- a. Pasien diupayakan agar sekret/dahak yang keluar menjadi encer sehingga mudah untuk dikeluarkan yaitu dengan minum air sedikitnya 1500-2500 ml/hari kecuali dilarang dokter.
- b. Melakukan teknik batuk yang efektif.
- c. Mengingatkan pasien saat batuk untuk menutup mulut dengan saputangan atau kain.
- d. Siapkan wadah untuk membuang dahak yang di dalamnya sudah diberikan cairan anti kuman

2. Latihan Batuk Efektif

Latihan batuk efektif merupakan latihan batuk untuk mengeluarkan secret / dahak

- a. Persiapan alat
 - 1) Wadah dahak tertutup
 - 2) Cairan pembunuh kuman (lisol 2-3%)
 - 3) Handuk pengalas
 - 4) Bantal (jika diperlukan)
 - 5) Tissue
- b. Langkah-langkah Tindakan
 - 1) Tarik napas dalam lewat hidung (seperti cara nafas dalam 3-5 kali)
 - 2) Batukkan secara menghentak2 kali, batuk pertama untuk melepaskan mukus (lender) dan batuk kedua untuk mengeluarkan dahak. Jika pasien merasa nyeri pada saat batuk, tekan dada dengan bantal. Tampung dahak dengan wadah dahak yang berisi cairan anti kuman.

- 3) Tarik napas pendek cepat secara bergantian (menghirup) untuk mencegah mukus bergerak kembali ke jalan napas yang sempit
- 4) Istirahat

3. Menyiapkan Pot Sputum (Wadah dahak)

Menyiapkan wadah dahak untuk penderita saat batuk / meludah

Tujuan: Mencegah penularan penyakit, menghindari bau yang tidak nyaman, membunuh kuman.

- a. Peralatan yang diperlukan
 - 1) Wadah yang tertutup
 - 2) Cairan lisol atau sejenisnya
- b. Langkah-langkah tindakan :
 - 1) Cuci tangan
 - 2) Wadah/tempat ludah yang bersih dimasukkan larutan lisol 2-3% sebanyak 5-10 ml kemudian ditutup
 - 3) Cuci tangan

4. Demam

Demam adalah suatu bagian penting dari mekanisme pertahanan tubuh melawan infeksi. Meningkatnya suhu tubuh beberapa derajat dapat membantu tubuh melawan infeksi. Upaya yang dapat dilakukan oleh keluarga untuk menurunkan suhu tubuh penderita adalah:

- a. Jangan membungkus orang yang menderita demam. Singkirkan baju atau selimut yang berlebihan. Lingkungan sebaiknya sejuk nyaman. Contoh, gunakan satu lapis baju tipis dan satu selimut tipis untuk tidur. Jika ruangan panas, nyalakan AC atau kipas angin.

- b. Mandi atau menyeka/kompres tubuh dengan air hangat kuku dapat membantu mendinginkan seseorang dengan demam.
- c. Jangan mandi dengan air dingin atau kompres dengan alkohol. Ini akan mendinginkan kulit tetapi seringkali membuat situasi menjadi lebih buruk karena menyebabkan menggigil yang mana dapat meningkatkan suhu dalam tubuh.
- d. Minum cairan lebih banyak.

5. Memberi Kompres Hangat

Memberikan rasa hangat pada pasien dengan menggunakan cairan atau alat yang menimbulkan hangat pada bagian tubuh yang memerlukannya.

Tujuan: Memperlancar peredaran darah, memberi rasa nyaman/hangat dan tenang dan menurunkan suhu tubuh (pada pasien demam/menggigil)

- a. Persiapan alat
 - 1) Baskom berisi air hangat
 - 2) Kain/handul kecil (washlap) beberapa potong sesuai kebutuhan
 - 3) Perlak / pengalas
- b. Langkah-langkah tindakan
 - 1) Mencuci tangan
 - 2) Menjelaskan tindakan yang akan dilakukan
 - 3) Membawa alat-alat kedekat pasien
 - 4) Membentangkan pengalas dibawah tempat yang akan dikompres
 - 5) Memasukkan washlap kedalam air hangat dan diperas sampai lembab
 - 6) Meletakkan washlap tersebut pada bagian yang akan di-kompres.

- 7) Mengganti washlap bila kering dengan washlap yang sudah terendam dalam air hangat. Diulang sampai suhu badan turun
- 8) Merapikan pasien bila tindakan telah selesai.
- 9) Membereskan alat-alat.
- 10) Mencuci tangan
- c. Hal-hal yang perlu diperhatikan
 - 1) Kain (washlap) harus diganti pada waktunya dan suhu kompres dipertahankan tetap hangat
 - 2) Cairan jangan terlalu panas, hindarkan kulit terbakar (suhu cairan 40-46°C).

6. Sesak Napas

Sesak napas adalah suatu perasaan subyektif tentang kesulitan atau ketidaknyamanan dalam bernapas, merupakan petunjuk tubuh membutuhkan oksigen. Upaya yang dapat dilakukan oleh keluarga untuk mengatasi sesak napas adalah:

- a. Atur posisi duduk penderita, dengan memberikan posisi setengah duduk
- b. Memberikan latihan napas dalam
- c. Mengusahakan agar di rumah ada lubang angin dan jendela kamar yang selalu terbuka pada siang hari sehingga akan memudahkan terjadinya pertukaran udara.

7. Latihan Napas Dalam

Latihan nafas dalam merupakan bentuk latihan napas yang terdiri atas pernapasan perut (*abdominal/diafragma*) dan *pursed lip breathing*.

Tujuan: Memungkinkan napas dalam secara penuh dengan sedikit usaha. *Pursed lip breathing* membantu penderita mengontrol pernapasan yang berlebihan.

- a. Persiapan Pasien

- 1) Beri tahu maksud dan tujuan tindakan
 - 2) Pastikan bahwa pasien memahami penjelasan.
- b. Langkah-langkah tindakan:
- 1) Cuci tangan, dan gunakan peralatan perlindungan diri
 - 2) Atur posisi yang nyaman bagi klien dengan posisi setengah duduk di tempat tidur atau di kursi atau posisi berbaring di tempat tidur dengan satu bantal
 - 3) Berikan posisi fleksi (tekuk) lutut klien untuk merilekskan otot perut
 - 4) Tempatkan satu atau dua tangan pada perut, tepat di bawah tulang iga (rusuk)
 - 5) Tarik napas melalui hidung, jaga mulut tetap tertutup. Hitung sampai 3 selama menarik napas (inspirasi).
 - 6) Konsentrasi dan rasakan gerakan naiknya otot perut sejauh mungkin, tetap dalam kondisi relaks dan cegah lengkung pada punggung. Jika ada kesulitan menaikkan abdomen, ambil napas dengan cepat, lalu napas kuat lewat hidung.
 - 7) Hembuskan udara lewat bibir seperti meniup dan ekspirasi (menghembuskan udara) secara perlahan dan kuat sehingga terbentuk suara hembusan tanpa mengembungkan pipi.
 - 8) Konsentrasi dan rasakan turunnya abdomen dan kontraksi otot abdomen ketika ekspirasi. Hitung sampai 7 selama ekspirasi.
 - 9) Gunakan latihan ini setiap kali merasakan napas pendek dan tingkatkan secara bertahap selama 5-10 menit, dan dilakukan 4 kali sehari.
 - 10) Cuci tangan.

8. Penatalaksanaan Diet

Penderita yang mempunyai masalah pernapasan mungkin sulit mempertahankan nutrisi dan kebutuhan cairannya. Kadang-kadang penderita tidak kuat mengunyah karena energi yang ada digunakan untuk bernapas atau ketika sedang makan kadang-kadang terjadi batuk dan sesak napas. Upaya pertolongan yang dapat dilakukan keluarga adalah:

- a. Memastikan obat batuk sudah diminum
- b. Memotivasi dan membantu penderita makan makanan yang mudah dikunyah dan ditelan.
- c. Memberikan makanan sedikit demi sedikit namun sering dan yang mengandung gizi yaitu tinggi kalori dan protein. Bahan makanan sumber kalori/karbohidrat seperti nasi, roti, mie dan hasil olahan tepung (seperti cake, pudding), dodol ubi serta gula pasir. Bahan makanan sumber protein hewani seperti daging sapi, ayam, ikan, telur, susu, dan hasil olahannya seperti keju. Bahan makanan sumber protein nabati seperti semua jenis kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tempe dan tahu.

9. Lingkungan Rumah Untuk Penderita TB paru

Pada umumnya, lingkungan rumah yang buruk (tidak memenuhi syarat kesehatan) akan berpengaruh pada penyebaran penyakit menular termasuk penyakit TB paru, berikut ini akan diuraikan mengenai lingkungan fisik dan sosial rumah yang berpengaruh terhadap kejadian TB paru.

- a. Kelembaban Udara

Kelembaban udara dalam rumah minimal 40% - 70%. Bakteri *mycobacterium T tuberculosis* seperti halnya bakteri lain, akan tumbuh dengan subur pada

lingkungan dengan kelembaban tinggi karena air membentuk lebih dari 80% volume sel bakteri dan merupakan hal yang menunjang untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel bakteri.

b. Ventilasi rumah

Ventilasi (lubang hawa) adalah proses penyediaan udara segar dan pengeluaran udara kotor secara alamiah atau mekanis. Lubang ventilasi harus memenuhi aturan sebagai berikut:

- 1) Luas bersih dari jendela/lubang hawa sekurang-kurangnya 1/10 dari luas lantai rumah.
- 2) Jendela/lubang hawa harus meluas ke arah atas sampai setinggi minimal 1,95 meter dari permukaan lantai.
- 3) Adanya lubang udara yang berlokasi di bawah langit-langit sekurang - kurangnya 0,35% luas lantai ruang yang bersangkutan.

Ventilasi juga berfungsi untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri terutama bakteri patogen. Ada 2 macam ventilasi :

- 1) Ventilasi alamiah yaitu aliran udara di dalam ruangan tersebut secara alamiah melalui jendela, pintu, lubang angin, lubang-lubang pada dinding dan sebagainya.
- 2) Ventilasi buatan yaitu menggunakan alat-alat khusus untuk mengalirkan udara, misalnya kipas angin dan mesin penghisap udara.

c. Suhu Ruangan

Suhu adalah panas atau dinginnya udara yang dinyatakan dengan satuan derajat tertentu. Suhu rumah yang ideal adalah berkisar antara 18-20°C. Bakteri *mycobacterium tuberculosis* memiliki rentang

suhu yang disukai, tetapi di dalam rentang ini terdapat suatu suhu optimum saat mereka tumbuh pesat. *Mycobacterium tuberculasa* merupakan bakteri mesofilik yang tumbuh subur dalam rentang suhu 25-40°C, akan tetapi akan tumbuh secara optimal pada suhu 31-37°C.

d. Pencerahan Rumah

Pencerahan alami ruangan rumah adalah penerangan yang bersumber dari sinar matahari (alami), yaitu semua jalan yang memungkinkan untuk masuknya cahaya matahari alamiah, misalnya melalui jendela atau genteng kaca. Cahaya berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1) Cahaya Alamiah

Cahaya alamiah yakni matahari. Cahaya ini sangat penting, karena dapat membunuh bakteri-bakteri berbahaya di dalam rumah, misalnya kuman TBC. Oleh karena itu, rumah yang cukup sehat seyogyanya harus mempunyai jalan masuk yang cukup (jendela), luasnya sekurang-kurangnya 15-20% dari luas lantai. Perlu diperhatikan agar sinar matahari dapat langsung ke dalam ruangan, tidak terhalang oleh bangunan lain. Fungsi jendela disini selain sebagai ventilasi, juga sebagai jalan masuk cahaya. Selain itu jalan masuknya cahaya alamiah juga diusahakan dengan genteng kaca.

2) Cahaya Buatan

Cahaya buatan yaitu cahaya yang menggunakan sumber cahaya yang bukan alamiah, seperti lampu minyak tanah, listrik, api dan lain-lain. Kualitas dari cahaya buatan tergantung dari terangnya sumber cahaya (*brightness of the source*).

e. Kepadatan Penghuni

Kepadatan penghuni dalam satu rumah, akan memberikan pengaruh bagi penghuninya. Luas rumah yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan kapasitas terlalu padat (*overcrowded*). Kondisi ini tidak sehat karena disamping menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen, juga bila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi, terutama tuberkulosis akan mudah menular kepada anggota keluarga yang lain. Luas bangunan yang optimum adalah apabila dapat menyediakan 2,5-3m² untuk setiap orang (setiap anggota keluarga).

BAB 6

PROGRAM TUBERKULOSIS DI INDONESIA

A. Program Pengendalian Tuberkulosis (TB)

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium Tuberculosis*). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya (Depkes RI, 2007). Tuberkulosis adalah penyakit infeksi terutama menyerang parenkim paru. Tuberculosis dapat juga ditularkan ke bagian tubuh lainnya, termasuk meninges, ginjal, tulang, dan nodus limfe. Agen infeksi utama *Mycobacterium tuberculosis*, adalah batang aerobik tahan asam yang tumbuh dengan lambat dan sensitive terhadap panas dan sinar ultraviolet (Smeltzer & Bare, 2001). Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tuberculosis adalah suatu penyakit menular terutama menyerang paru tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*.

Sumber penularan adalah pasien TB dengan BTA positif. Pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak (*droplet nucleid*). Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3000 percikan dahak. Orang dapat terinfeksi apabila droplet tersebut terhirup ke dalam saluran nafas. Umumnya penularan terjadi dalam ruangan, dimana percikan dahak berada dalam waktu yang lama. Daya penularan seorang

pasien ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat kepositifan hasil pemeriksaan dahak, makin menular pasien tersebut. Pada orang dengan daya tahan tubuh yang lemah, misalnya pasien HIV, gizi kurang (malnutrisi), semakin berpeluang besar untuk menderita TB paru. Kuman TB dapat bersifat dormant (tidur/tidak berkembang), namun pada suatu saat kuman tersebut dapat aktif kembali apabila daya tahan tubuh seseorang menurun sehingga menjadi sakit TB.

Direct Observer Treatment Short Course (DOTS) merupakan strategi pengendalian TB yang terdiri dari 5 (lima) komponen kunci yaitu : (1) Komitmen politis, dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan, (2) Penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya, (3) Pengobatan yang standar, dengan supervisi dan dukungan bagi pasien, (4) Sistem pengelolaan dan ketersediaan OAT (obat anti tuberkulosis) yang efektif, (5) Sistem monitoring pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program (Depkes, 2011).

Semakin berkembang tantangan yang dihadapi program di berbagai negara, *Global Stop TB partnership* memperluas strategi DOTS sebagai berikut: (1). Mencapai, mengoptimalkan dan mempertahankan mutu DOTS, (2) Merespon masalah TB-HIV, MDR-TB dan tantangan lain, (3) Berkontribusi dalam menguatkan sistem kesehatan, (4) Memberdayakan pasien dan masyarakat, (5) Melaksanakan dan mengembangkan penelitian (Depkes, 2011).

Program Temukan, Obati Sampai Sembuh (TOSS) TBC merupakan sebuah gerakan atau kampanye untuk Temukan Tuberkulosis, Obati Sampai Sembuh TBC di Indonesia, menyembuhkan pasien TBC, serta menghentikan penularan

TBC di masyarakat. TOSS TBC menargetkan 90 persen penurunan insiden TBC dan 95 persen penurunan kematian TBC pada tahun 2030. Langkah-langkah yang dilakukan TOSS TBC meliputi, mencari dan menemukan gejala di masyarakat, mengobati TBC dengan tepat, hingga memantau pengobatan TBC sampai sembuh.

Adapun prinsip dan strategi TOSS TBC adalah: (1) Penguatan dan kepemimpinan program TB, (2) Meningkatkan akses layanan TB yang bermutu, (3) Pengendalian factor resiko, (4) Penguatan kemitraan TB melalui forum koordinasi, (5) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian TB, (6) Memperkuat system kesehatan dan manajemen TB.

B. Eliminasi Tuberkulosis (TB) di Indonesia

Eliminasi TBC adalah upaya untuk mengakhiri epidemi TBC, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. TBC merupakan penyakit kronis yang dapat menular melalui udara, sehingga dapat menyebar di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan tempat umum lainnya.

Untuk mencapai eliminasi TBC, Indonesia menargetkan penurunan insiden TBC menjadi 65/100.000 penduduk pada tahun 2030. Pemerintah telah memiliki payung hukum untuk menanggulangi TBC, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menekan penularan TBC, di antaranya: Mencuci tangan secara teratur, Menghindari kontak dekat dengan penderita TBC, Memastikan sirkulasi udara yang baik di ruangan, Mengenakan masker ketika diperlukan, Segera mencari

bantuan medis jika mengalami gejala TBC. Penderita TBC dapat dikatakan sembuh total jika hasil pemeriksaan tes dahak (BTA) memiliki hasil negatif.

Adapun tahapan eliminasi TBC untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana dibawah ini:

1. Tahap 1 (Tahun 2016)

Dilakukan:

- a. Peluncuran Strategi TOSS-TBC, penemuan Intensif, Aktif, Masif, serta
- b. Kemitraan dan mobilisasi sosial dengan langkah-langkah:
 - 1) Penguatan PPM (Public Private Mix – Kemitraan jaringan Pemerintah dan Swasta) dan penerapan penemuan aktif
 - 2) Pemanfaatan TCM (Tes Cepat Molekuler) dan mikroskopis
 - 3) Desentralisasi kegiatan kepada Kabupaten/kota
 - 4) Penguatan regulasi dan kepemimpinan program
 - 5) Menerapkan exit strategy ketergantungan dari donor
 - 6) Penerapan kegiatan penurunan risiko penularan
 - 7) Penerapan shortterm regiment (pengobatan jangka pendek) untuk MDR-TB
 - 8) Akselerasi pengobatan kasus TBC mencapai 70% dan angka keberhasilan pengobatan diatas 85%.

2. Tahap 2 (Tahun 2020)

Target yang akan dicapai pada tahun 2020 yaitu 30% penurunan insiden TBC serta 40% penurunan kematian TBC dibandingkan tahun 2014 dengan langkah-langkah:

- a. Mempertahankan cakupan pengobatan tetap diatas 70% dan angka kesuksesan pengobatan diatas 85%.

- b. Optimalisasi desentralisasi kegiatan TBC kepada Kabupaten/kota.
- c. Mencegah pembiayaan katastrofik TBC
- d. Penguatan pengendalian faktor risiko : profilaksis dan pengobatan TBC laten.
- e. Maksimalisasi pemanfaatan diagnosis TCM dan mikroskopis
- f. Desentralisasi kegiatan kepada Kabupaten/kota
- g. Penerapan *short term regiment* (pengobatan jangka pendek) untuk TBC sensitif.

3. Tahap 3 (Tahun 2025)

Target yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah 50% penurunan insiden TBC serta 70% penurunan kematian TBC dibandingkan tahun 2014 dengan langkah-langkah:

- a. Mempertahankan cakupan pengobatan tetap diatas 80% dan angka kesuksesan pengobatan diatas 95%.
- b. Menerapkan cakupan semesta untuk TBC
- c. Mengendalikan pembiayaan katastrofik TBC
- d. Akselerasi pengobatan profilaksis dan pengobatan TBC laten
- e. Inovasi diagnosis TBC
- f. Penguatan surveilans TBC
- g. Penerapan short term regiment (pengobatan jangka pendek) untuk laten TBC
- h. Penerapan vaksin TBC

4. Tahap 4 (Tahun 2030)

Target yang akan dicapai pada tahun 2030 adalah 90% penurunan insiden TBC dan 95% penurunan kematian TBC dibandingkan tahun 2014.

C. Tatalaksana Pasien TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Penemuan Pasien TB

Penemuan pasien TB, secara umum dilakukan secara pasif dengan promosi aktif. Penjangkaran terduga pasien dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, didukung dengan penyuluhan secara aktif, baik oleh petugas kesehatan maupun masyarakat, untuk meningkatkan cakupan penemuan terduga pasien TB. Penemuan secara aktif pada masyarakat umumnya dinilai tidak cost effective, namun dapat efektif apabila dilakukan terhadap : (1) kelompok khusus yang rentan atau berisiko tinggi sakit TB seperti pada pasien HIV dan DM, (2) kelompok yang rentan tertular TB seperti di Rutan, Lapas, masyarakat yang hidup di daerah kumuh, serta keluarga atau kontak pasien TB, terutama pada pasien TB dengan BTA positif, (3) kontak pasien TB anak dibawah lima tahun untuk menemukan sumber penularan, (4) kontak erat dengan pasien TB BTA positif dan pasien TB resisten obat.

2. Identifikasi Terduga Pasien TB

Terduga pasien TB adalah seseorang yang mempunyai keluhan atau gejala klinis mendukung TB (suspek TB). Biasanya terduga TB datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan berbagai keluhan dan gejala klinis yang mungkin menunjukkan bahwa yang bersangkutan termasuk terduga TB. Gejala utamanya adalah batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih dan gejala tambahan. Gejala tambahan yang sering dijumpai adalah : (1) gejala respiratorik ; dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas dan nyeri dada, (2) gejala sistemik; badan lemah, nafsu makan menurun, berat badan turun, rasa kurang enak badan (malaise), pada malam hari walaupun tanpa kegiatan, demam meriang

yang berulang lebih dari satu bulan. Perlu diketahui bahwa gejala tersebut dapat di jumpai pada penyakit paru selain TB.

3. Pemeriksaan dahak

Pemeriksaan dahak berfungsi untuk menegakkan diagnosis, menilai keberhasilan pengobatan dan menentukan potensi penularan. Pemeriksaan dahak untuk penegakan diagnosis dilakukan dengan mengumpulkan 3 spesimen dahak yang dikumpulkan dalam dua hari kunjungan yang berurutan berupa Sewaktu-Pagi-Sewaktu (SPS): S (sewaktu): dahak dikumpulkan pada saat suspek TB datang berkunjung pertama kali. Pada saat pulang, suspek membawa sebuah pot dahak untuk mengumpulkan dahak pagi pada hari kedua. P (Pagi): dahak dikumpulkan di rumah pada pagi hari kedua, segera setelah bangun tidur. Pot dibawa dan diserahkan sendiri kepada petugas di Unit Pelayanan Kesehatan (UPK). S (sewaktu): dahak dikumpulkan di UPK pada hari kedua, saat menyerahkan dahak pagi.

4. Pengobatan Pasien TB

Pengobatan TB bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap Obat Anti Tuberkulosis (OAT).

5. Tahapan Pengobatan TB

Pengobatan TB harus selalu meliputi pengobatan tahap awal dan tahap lanjutan dengan tujuan: (1) tahap awal, pengobatan diberikan setiap hari. Panduan pengobatan pada tahap ini adalah secara efektif menurunkan jumlah kuman yang ada dalam tubuh pasien dan menurunkan pengaruh dari sebagian kecil kuman yang mungkin sudah resisten sejak sebelum pasien

mendapatkan pengobatan. Pengobatan awal pada semua pasien baru harus diberikan selama 2 bulan. Pada umumnya dengan pengobatan secara teratur dan tanpa adanya penyulit, daya penularan sudah sangat menurun setelah pengobatan selama 2 minggu, (2) tahap lanjutan, pengobatan tahap lanjutan merupakan tahap yang penting untuk membunuh sisa kuman yang masih ada dalam tubuh khususnya kuman *persister* sehingga pasien dapat sembuh dan mencegah kekambuhan.

6. Obat Anti Tuberkulosis (OAT)

Tabel 6.1: Obat Anti Tuberkulosis lini pertama

Jenis OAT	Sifat	Efek samping
Isoniazid (H)	Bakteriosidal	Neuropati perifer, psikosis toksis, gangguan fungsi hati, kejang
Rifampicin (R)	Bakteriosidal	Flu syndrome, gangguan gastrointestinal, urine berwarna merah, gangguan fungsi hati, trombositopeni, demam, skin rash, sesak nafas, anemia hemolitik
Pyrazinamide (Z)	Bakteriosidal	gangguan gastrointestinal, gangguan fungsi hati, gout arthritis
Streptomycin (S)	Bakteriosidal	Nyeri di tempat suntikan, gangguan keseimbangan dan pendengaran, renjatan anafilaktik,

		anemia, agranulositosis, trombositopeni
Ethambutol (E)	Bakteriostatik	Gangguan penglihatan, buta warna, neuritis perifer

Tabel 6.1 Obat Anti Tuberkulosis lini pertama

7. Panduan OAT yang digunakan

Paduan OAT yang digunakan oleh Program Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia (sesuai rekomendasi WHO dan ISTC), adalah:

a. Kategori 1: 2(HRZE)/4(HR)3.

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien dengan kriteria: (1) Pasien baru TB paru BTA positif; (2) Pasien TB paru BTA negatif foto toraks positif; dan (3) Pasien TB ekstra paru

b. Kategori 2: 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3.

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang telah diobati sebelumnya, dengan kriteria: (1) pasien kambuh; (2) pasien gagal; dan (3) pasien dengan pengobatan setelah putus berobat (*default*).

c. Kategori Anak: 2HRZ / 4HR

Paduan OAT kategori-1 dan kategori-2 disediakan dalam bentuk paket berupa obat Kombinasi Dosis Tetap (OAT-KDT), sedangkan kategori anak sementara ini disediakan dalam bentuk OAT kombipak. Tablet OAT KDT ini terdiri dari kombinasi 2 atau 4 jenis obat dalam satu tablet. Dosisnya disesuaikan dengan berat badan pasien. Paduan ini dikemas dalam satu paket untuk satu pasien. Paket Kombipak adalah paket obat lepas yang terdiri dari Isoniasid, Rifampisin,

Pirazinamid dan Etambutol yang dikemas dalam bentuk blister. Paduan OAT ini disediakan untuk digunakan dalam pengobatan pasien yang mengalami efek samping OAT KDT. Paduan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) disediakan dalam bentuk paket, dengan tujuan untuk memudahkan pemberian obat dan menjamin kelangsungan (kontinuitas) pengobatan sampai selesai. Satu (1) paket untuk satu (1) pasien dalam satu (1) masa pengobatan.

8. Hasil Pengobatan

- a. Sembuh: pasien telah menyelesaikan pengobatannya secara lengkap dan pemeriksaan ulang dahak (*follow-up*) hasilnya negatif pada Akhir Pengobatan (AP) dan minimal satu pemeriksaan follow-up sebelumnya negatif.
- b. Pengobatan lengkap: adalah pasien yang telah menyelesaikan pengobatannya secara lengkap tetapi tidak memenuhi persyaratan sembuh atau gagal.
- c. Meninggal: adalah pasien yang meninggal dalam masa pengobatan karena sebab apapun.
- d. Pindah: adalah pasien yang pindah berobat ke unit dengan register TB 03 yang lain dan hasil pengobatannya tidak diketahui.
- e. *Default* (Putus berobat): adalah pasien yang tidak berobat 2 bulan berturut-turut atau lebih sebelum masa pengobatannya selesai.
- f. Gagal: pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan.

D. Pengawas Menelan Obat (PMO)

Salah satu komponen DOTS adalah pengobatan paduan OAT jangka pendek dengan pengawasan langsung,

untuk menjamin keteraturan pengobatan diperlukan seorang Pengawas Menelan Obat (PMO). Tugas seorang PMO adalah (1) mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan, (2) memberi dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur, (3) mengingatkan pasien untuk periksa ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan, (4) memberikan penyuluhan pada anggota keluarga pasien TB yang mempunyai gejala-gejala mencurigakan TB untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pengawas Menelan Obat dapat dilakukan oleh petugas kesehatan, kader kesehatan, tokoh masyarakat atau anggota keluarga. Persyaratan sebagai PMO adalah (1) orang yang telah dikenal, dipercaya dan disetujui oleh pasien dan petugas kesehatan serta disegani dan dihormati oleh pasien, (2) seseorang yang tinggal dekat dengan pasien, (3) bersedia membantu pasien dengan sukarela, (4) bersedia dilatih dan atau mendapat penyuluhan bersama-sama dengan pasien.

Kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan salah satu anggota keluarga sebagai pengawas menelan obat dalam program pengobatan TB, diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan program pengobatan pasien TB paru karena adanya tanggungjawab anggota keluarga sebagai PMO terhadap anggota keluarga yang menderita penyakit TB untuk memberikan perawatan dan berbagai tugas dalam melakukan pengawasan dan perawatan (*care*), kedekatan hubungan antar anggota keluarga akan terjalin rasa saling percaya (*trust*), kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan dengan pasien TB (*empathy*), perasaan cinta dan kasih sayang yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga karena rasa saling memiliki antar anggota keluarga.

BAB 7

PENUTUP

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan kemandirian individu dan keluarga dalam menyelesaikan masalah kesehatan pada pasien dengan TBC. Berdasarkan hasil kajian di lapangan dan studi literature tentang promosi kesehatan dan literasi kesehatan maka dikembangkan model pemberdayaan PMO berbasis model promosi dan literasi kesehatan.

Tujuan pengembangan model promosi dan literasi kesehatan untuk mempercepat proses pemutusan rantai penularan penyakit TBC melalui peningkatan kemandirian PMO dalam memberikan perawatan pasien TBC di keluarga. Sehingga target capaian keberhasilan program TBC dalam menurunkan prevalensi penyakit TBC dapat tercapai.

Model promosi dan literasi kesehatan, sebagai pendekatan untuk kemandirian individu dan keluarga melalui peningkatan efikasi diri, komitmen bertindak yang didasari oleh kemampuan memahami masalah kesehatan (literasi kesehatan). Secara empiris model ini telah diaplikasikan pada PMO – pasien TBC dengan hasil yang signifikan dan efektif untuk meningkatkan kemandirian.

Melalui buku ini, kami telah menekankan pentingnya perilaku promosi kesehatan dan literasi kesehatan sebagai kunci utama dalam kemandirian keluarga. Perilaku promosi kesehatan adalah upaya keluarga untuk berperilaku sehat karena adanya manfaat yang dirasakan, efikasi diri, dukungan keluarga dan komitmen untuk bertindak. Literasi kesehatan merupakan kemampuan keluarga untuk memahami informasi kesehatan

dan keperawatan, serta kemampuan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi tersebut. Dengan meningkatkan perilaku promosi dan literasi kesehatan, keluarga mampu:

1. Mengenali gejala awal penyakit TBC dan bertindak cepat untuk mendapatkan pertolongan medis.
2. Membantu anggota keluarga yang memiliki risiko tinggi untuk mengelola kondisi kesehatan mereka.
3. Menciptakan lingkungan yang mendukung pola hidup sehat dan bebas stres.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas dalam upaya pencegahan TBC. Untuk memperkuat dampak pemberdayaan ini, kami merekomendasikan beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan:

1. Edukasi dan Supervisi Berkelanjutan
Penyelenggaraan program pendidikan kesehatan di tingkat keluarga dan komunitas serta supervisi melalui kunjungan rumah untuk meningkatkan pemahaman tentang TBC dan pencegahannya.
2. Kerja Sama dengan Layanan Kesehatan
Mendorong kolaborasi antara keluarga dan penyedia layanan kesehatan untuk pemantauan risiko penularan TBC pada keluarga.
3. Penggunaan Teknologi
Memanfaatkan aplikasi kesehatan dan media digital sebagai alat bantu untuk edukasi dan pemantauan kesehatan.
4. Kebijakan yang Mendukung
Pemerintah dan lembaga terkait perlu mendukung pemberdayaan keluarga melalui kebijakan yang mempermudah akses terhadap informasi kesehatan dan layanan medis.

Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa pencegahan TBC adalah tanggung jawab bersama. Keluarga yang teredukasi dan terampil dalam mengelola risiko kesehatan akan menjadi ujung tombak dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif. Dengan semangat kolaborasi, kepedulian, dan kesadaran, mari kita wujudkan masyarakat yang bebas dari ancaman TBC.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang telah mengikuti pembahasan dalam buku ini. Semoga informasi dan wawasan yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi Anda dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, H. (2012). *The Role of Drop Out Cases DOT of Smear Positive of Pulmonary Tuberculosis in Working Area Public Health Center of Sukowono Jember*.<http://digilib.unej.ac.id>. diakses 12 September 2023.
- Alyssa F, Joey L. (2012). *Patient and provider level risk factors associated with default from tuberculosis treatment, South Africa, 2002: a case control study*, BMC Public Health, www.biomedcentral.com/1471-2458/12/56, 1-12 halaman
- Anderson, E.T.; McFarlane, J. (2008). *Community as Partner: Theory and Practice in Nursing, 5th Edition*. Lippincott Williams & Wilkins
- Arohi Chauhan, Malik Parmar, Girish C Dash, et.al. (2024). Health literacy and tuberculosis control: systematic review and meta analysis. Bulletin World Health Organisation 2024;102:421–431| doi: <http://dx.doi.org/10.2471/BLT.23.290396>.
- Arohi Chauhan, Malik Parmar, Girish C Dash, et.al. (2024). Health literacy and tuberculosis control: systematic review and meta analysis. Bulletin World Health Organisation 2024;102:421–431| doi: <http://dx.doi.org/10.2471/BLT.23.290396>.
- Arohi Chauhan, Malik Parmar, Girish C Dash, et.al. (2024). Health literacy and tuberculosis control: systematic review and meta analysis. Bulletin World Health Organisation 2024; 102: 421–431| doi: <http://dx.doi.org/10.2471/BLT.23.290396>.
- Atiek T.A. (2012). *The Effort of Community Empowerment in Tuberculosis Disease Control Program in Tambakrejo*

Public Health Center Surabaya City. Journal Administrasi Kebijakan Kesehatan. Vol.10.No.2 Halaman: 79-86.

- Atkins S, Lewin S. (2011). *Provider experiences of implementation of a new tuberculosis treatment programme: a qualitative study using the normalisation process model.* BMC Health Service Research,<http://www.biomedcentral.com/1472-6963/11/275>. Halaman 1-12, diakses tgl.6 /12/2013 jam 09.14.
- Ayisi J.G, Hoog A.H. (2011). *Care seeking and attitudes towards treatment compliance by newly enrolled tuberculosis patients in the district treatment programme in rural western Kenya: a qualitative study.* BMC Public Health.<http://biomedcentral.com/1471-2458/11/515>. Halaman 1 – 10.
- Bandura, A. (1977). Self Efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84, 191-215.
- Bandura, A. (1997). *Self Efficacy: The exercise of control.* New York: Freeman and Company.
- Bandura, A. (2009). *Self Efficacy- in Change Society.* Cambridge University Press, New York.
- Bare BG., Smeltzer SC. (2001). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah.* Jakarta:EGC. Hal. 45-47.
- Bomar, P.J. (2004). *Promoting health in families: Applying family research and theory to nursing practice.* Saunders:Lippincott
- Boogaard J, Msoka E. (2010). *An exploration of patient perceptions of adherence to tuberculosis treatment in Tanzania.*
- Cayla J.A, Rodrigo T. (2009). *Tuberculosis treatment adherence and fatality in Spain.* Respiratory Research,

<http://respiratoryresearch.com/content/10/1/1> Halaman 1-10.

- Clement I. (2009). *Basic Concept of Community Health Nursing, 2nd edition*, Jaypee Brothers Medical Publishers (p) Ltd, New Delhi
- Deci, E. L., Vansteenkiste, M. (2004). "Self-determination theory and basic need satisfaction: Understanding human development in positive psychology". *Research in Psychology* **27**: 17-34.
- Deci, E. L., Vansteenkiste, M. (2004). "Self-determination theory and basic need satisfaction: Understanding human development in positive psychology". *Research in Psychology* **27**: 17-34.
- Deci, E., & Ryan, R., (2002). *Handbook of self-determination research*. Rochester, NY: University of Rochester Press
- Deci, E., & Ryan, R., (2002). *Handbook of self-determination research*. Rochester, NY: University of Rochester Press
- Denise St-Cyr T, Frances G. (2008). *Empowerment Interventions, knowledge translation and exchange: perspectives of home care professionals, clients and caregivers*, MBC Health Service Research, dowloads from <http://www.biomedcentral.com/1472-6963/8/177> , 19 Nop 2023
- Depkes RI.(2012). *Pedoman Nasional Pengendalian TB-2012*. Jakarta
- Dunst CJ, Trivette CM.(1996) Empowerment, effective helping practices and family center care, *Pediatr Nurs* Juli – Agust, 22(4)334-7,343.
- Egwaga S, Range N. (2008). *Assessment of patient preference in allocation and observation of anti-tuberculosis medication in three districts in Tanzania*. Publisher and licensee Dove Medical Press Ltd.

- Elaine Ryder, Sula Wiltshire, (2011). *Understanding empowerment*. VOL: 97, ISSUE: 32, PAGE NO: 39
- Elizabeth T.Anderson, Judith Mc Farlane. (2011). *Community As Partner: Theory and Practice in Nursing*, 6th edition, Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams and Wilkin's.
- Euis Sunarti. (2006). *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi dan Keberlanjutannya*. Institut Pertanian Bogor.
- Fertman, Cl., & Allensworth, DD, (2010). *Health Promotion Program*. San Francisco, US: A Wiley Imprint.
- Fishbein, M and Azjen, I. (2010). *Predicting and changing behavior: The reasoned action approach*. New York: Psychology Press.
- Fishbein, M and Yzer, M.C. (2003). Using theory to design effective health behavior interventions. *Communication theory*, 13. 164-183.
- Friedman, Bowden, & Jones, (2003). *Family Nursing: Research, Theory and Practice*. (5th ed). New Jersey: PrenticeHall.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2010). Buku Ajar Keperawatan Keluarga Riset, Teori, & Praktik. EGC.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2010). Buku Ajar Keperawatan Keluarga Riset, Teori, & Praktik. EGC.
- Friedman, M.M. (1998). *Family Nursing, Theory and Practice*, Connecticut: Appleton & Lange.
- Friedman, M.M., Bowden, V.R., & Jones, E.G. (2010). *Buku ajar keperawatan keluarga: Riset, teori, dan praktik*, alih bahasa, Akhir Yani S. Hamid dkk; Ed 5. Jakarta: EGC
- Glenn Laverack (2005). *Public Health, Power, Empowerment, and Professional Practice*. Palgrave Macmillan, New York.
- Gonzales-Ochoa E, Brooks J.L. (2009). *Pulmonary tuberculosis case detection through fortuitous cough screening*

- during home visite. Tropical Medicine and International Health, Volume 14 No 2 pp 132 – 135.
- Graves,K.N.,and Shelton,T.L (2007). *Family empowerment as a mediator between family centered systems of care and changes in child functioning: identifying an important mechanism of change*. Journal of child & family studies, 16 (4), 556-566. Doi: 10.1007/s10826-006-91061.
- Graves,K.N.,and Shelton,T.L (2007). *Family empowerment as a mediator between family centered systems of care and changes in child functioning: identifying an important mechanism of change*. Journal of child & family studies, 16 (4), 556-566. Doi: 10.1007/s10826-006-91061.
- Green L, Kreuter M. (1991). *Health Promotion Planning: An educational and environmetal approach. 2nd edition*. Mountain View, CA: Myfield Publising Company.
- Hagman G, (2010). *The Artist's Mind: A Psychoanalytic Perspective on Creativity, Modern Art and Modern Artists*. Routledge.
- Hair, JF Black, W.C., Babin, B.J and Anderson, S.E. (2010). *Multivariat Data Analysis*. Seventh Edition. Pentice Hall, Upper Sandle River, New Jersey.
- Hensarling, J. (2009). *Development and psychometric testing of Henserling's diabetes family support scale*, a dissertation. Degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Texa's Women's University. Diakses dari www.proquest.com pada tanggal 8 Desember2010
- Heryanto dan Komalig, F. (2004). *Peran Pengawas Menelan Obat pada Kejadian Putus Berobat Pasien Tb Paru di DKI Jakarta th. 2002*, Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Vol.XV.No.2: 13 – 19.
- Heydari A, Khorashadizadeh F.(2014). Pender Health Promotion Model in Medical research. *Journal of The*

Pakistan Medical Association, Vol.64 No.9, pp.1067 – 1074.

- Iba Supra S dan Irna N (2024). Analisa Bagan Teori Promotion Health Model Nola J. Pender. AACENDIKIA: Journal of Nursing, Volume 3 (1), Juli 2024, p.20-27.
- Iba Supra S dan Irna N (2024). Analisa Bagan Teori Promotion Health Model Nola J. Pender. AACENDIKIA: Journal of Nursing, Volume 3 (1), Juli 2024, p.20-27.
- Ife, J.W. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*, Longman. Australia.
- Judith A.A, Cherie R, Kristine D.W. (2010). *Community Health Nursing: Promoting and Protecting The Public's Health, 7th edition*, Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams and Wilkin's.
- Judith G & John B. (2005). *Social Research Principles of Social Research*. Open University Press, England.
- Kamalam S, (2012). *Essentials in Community Health Nursing Practice, 2nd edition*, Jaypee Brothers Medical Publishers (p) Ltd, New Delhi
- Kemenkes RI (2014) *Panduan Nasional Pelayanan Keperawatan Tuberkulosis*. Jakarta.
- Kemenkes RI (2020) *Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia Tahun 2020 -2024*. Jakarta
- Kemenkes RI, (2016). Pedoman Umum Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Jakarta
- Kemenkes RI, (2016). Pedoman Umum Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Jakarta
- Kemenkes RI, (2016). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Jakarta

- Kemenkes RI, (2016). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Jakarta
- Khariroh S, Abdullah E, Ernawati, et.al. (2022). Health Promotion And Literacy Models To Increase The Autonomy Of Patients With Tuberculosis. Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan. Vol 7 (3) October 2022 (493-499). <https://doi.org/10.22216/jen.v7i3.1395>.
- Khariroh S, Abdullah E, Ernawati, et.al. (2022). Health Promotion And Literacy Models To Increase The Autonomy Of Patients With Tuberculosis. Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan. Vol 7 (3) October 2022(493-499). <https://doi.org/10.22216/jen.v7i3.1395>.
- Khariroh S, Abdullah E, Ernawati, et.al. (2022). Health Promotion And Literacy Models To Increase The Autonomy Of Patients With Tuberculosis. Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan. Vol 7 (3) October 2022(493-499). <https://doi.org/10.22216/jen.v7i3.1395>.
- Khariroh S, Abdullah E, Ernawati, et.al. (2022). Health Promotion And Literacy Models To Increase The Autonomy Of Patients With Tuberculosis. Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan. Vol 7 (3) October 2022(493-499). <https://doi.org/10.22216/jen.v7i3.1395>.
- Khariroh S, Abdullah E, Ernawati, et.al. (2022). Health Promotion And Literacy Models To Increase The Autonomy Of Patients With Tuberculosis. Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan. Vol 7 (3) October 2022(493-499). <https://doi.org/10.22216/jen.v7i3.1395>.
- Khariroh S, Abdullah E, Ernawati, et.al. (2022). Health Promotion And Literacy Models To Increase The Autonomy Of Patients With Tuberculosis. Jurnal Endurance: Kajian

Ilmiah Problema Kesehatan. Vol 7 (3) October 2022(493-499). <https://doi.org/10.22216/jen.v7i3.1395>.

Khariroh S, Abdullah E, Ernawati, et.al. (2022). Health Promotion And Literacy Models To Increase The Autonomy Of Patients With Tuberculosis. Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan. Vol 7 (3) October 2022(493-499). <https://doi.org/10.22216/jen.v7i3.1395>.

Khariroh S, Soedirham O, Abdullah E, et.al (2016). Model of Empowerment to Improve Autonomy Directly Observed Treatment (DOT) Tuberculosis Patients. International Journal of Public Health Science (IJPHS). Vol.5, No.2, pp. 164 - 169. <http://doi.org/10.11591/ijphs.v5i2>

Khariroh S, Soedirham O, Abdullah E, et.al (2016). Model of Empowerment to Improve Autonomy Directly Observed Treatment (DOT) Tuberculosis Patients. International Journal of Public Health Science (IJPHS). Vol.5, No.2, pp. 164 - 169. <http://doi.org/10.11591/ijphs.v5i2>.

Khariroh S, Soedirham O, Abdullah E, et.al (2016). Model of Empowerment to Improve Autonomy Directly Observed Treatment (DOT) Tuberculosis Patients. International Journal of Public Health Science (IJPHS). Vol.5, No.2, pp. 164 - 169. <http://doi.org/10.11591/ijphs.v5i2>.

Khariroh S, Soedirham O, Abdullah E, et.al (2016). Model of Empowerment to Improve Autonomy Directly Observed Treatment (DOT) Tuberculosis Patients. International Journal of Public Health Science (IJPHS). Vol.5, No.2, pp. 164 - 169. <http://doi.org/10.11591/ijphs.v5i2>.

Khariroh S, Soedirham O, Abdullah E, et.al (2016). Model of Empowerment to Improve Autonomy Directly Observed Treatment (DOT) Tuberculosis Patients. International Journal of Public Health Science (IJPHS). Vol.5, No.2, pp. 164 - 169. <http://doi.org/10.11591/ijphs.v5i2>.

- Khariroh S, Soedirham O, Abdullah E, et.al (2016). Model of Empowerment to Improve Autonomy Directly Observed Treatment (DOT) Tuberculosis Patients. *International Journal of Public Health Science (IJPHS)*. Vol.5, No.2, pp. 164 - 169. <http://doi.org/10.11591/ijphs.v5i2>.
- Khariroh S, Soedirham O, Abdullah E, et.al (2016). Model of Empowerment to Improve Autonomy Directly Observed Treatment (DOT) Tuberculosis Patients. *International Journal of Public Health Science (IJPHS)*. Vol.5, No.2, pp. 164 - 169. <http://doi.org/10.11591/ijphs.v5i2>
- Kickbusch I and Bandura H, (1991). Health Promotion Research: Toward a New Social Epidemiology. *European Series No.37*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
- Koentjoro, W. (2002). *Pendekatan Dukungan Sosial Keluarga*. Diakses dari www.e-psikologi.com/index.php pada tanggal 29 Maret 2023
- Lannon SL. (1997). Using health promotion model to enhance medication compliance. *Journal of Neuroscience Nursing*. Vol.29, pp 170-178.
- Lewis C.P and Newell J.N. (2009). *Improving tuberculosis care in low income countries: a qualitative study of patients' understanding of patient support in Nepal*. BMC Public Health, <http://www.biomedcentral.com/147/1-24589-190>. Halaman 2 – 8.
- Lima dias A.A, Falcao de oliveira D.M. (2013). *Life experiences of patients who have completed tuberculosis treatment: a qualitative investigation in southeast Brazil*. BMC Public Health, <http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/595>.
- Macq J, Torfoss T, Getahun H. (2007). *Patient empowerment in tuberculosis control: reflecting on past documented*

- experiences*, Tropical medicine and international Health, volume 12 no. 7 pp 873-883. Diakses tgl 26 Nop 2023.
- Marcia S, Jeanette L. (2010). *Foundations of Nursing in The Community Oriented Practice, Third Edition*, Mosby, inc., an affiliate of Elsevier Inc.
- Mary A.N, Melanie M.E. (2011). *Community/Public Health Nursing, Promoting the Health of Populations, 5th edition*, Sunders, an imprint of Elsevier Inc.
- Michaela B, Jayne T and Ken J. (2000). *Evidence on the Relationship between Low Income and Poor Health: Is the Government Doing Enough. Journal of Institute for Fiscal Studies* vol. 21, no. 3, pp. 375–399
- Moonan P.K, Quitugua T.N. (2011). *Does directly observed therapy (DOT) reduce drug resistant tuberculosis?. BMC Public Health*, <http://biomedcentral.com/1471-2458/11/19>. Pp. 1-8.
- Mutire BN and Kerana MN.(2011). Factors associated with default from treatment among tuberculosis patients in Nairobi Province, Kenya : A case control study, *BMC Public Health*, <http://www.biomedcentral.com/147-2458/11/696>.pp. 2-10.
- Notoatmodjo S., (2007). *Perilaku kesehatan dan ilmu perilaku*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S., (2012). *Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam. (2003). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta. Salemba Medika.
- Olds DL, Kitzman H, Cole R, Robinson J, Sidora K, Luckey DW, Henderson CR, Hanks C, Bondy J, Holmberg J . (2004). *Effects of nurse home-visiting on maternal life course*

and child development: age 6 follow-up results of a randomized trial. Pediatrics, 114(6):1550-1559.

[PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)

- Olds DL, Robinson J, O'Brien R, Luckey DW, Pettitt LM, Henderson CR, Ng RK, Sheff KL, Korfmacher J, Hiatt S, Talmi A (2002). *Home visiting by paraprofessionals and by nurses: a randomized, controlled trial. Pediatrics, 110(3):486-496.* [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
- Payne, M. (1997). *Social Work and Community Care*. London. Mc.Millan.
- Paz-soldan A.V, Alban E.R. (2013). *The provision of and need for social support among adult and pediatric patients with tuberculosis in lima, Peru : a qualitative study*, BMC health services research, <http://www.biomedcentral.com/1472-6963/13/290>.
- Pender, N.J. (2006). *Health Promotion in Nursing Practice (5th.ed)*. Boston, MA: Pearson.
- Pender, N.J. (2006). *Health Promotion in Nursing Practice (5th.ed)*. Boston,MA: Pearson.
- Pender, N.J. (2006). *Health Promotion in Nursing Practice (5th.ed)*. Boston,MA: Pearson.
- Pender, N.J. (2006). *Health Promotion in Nursing Practice (5th.ed)*. Boston, MA: Pearson.
- Pender, N.J. (2006). *Health Promotion in Nursing Practice (5th.ed)*. Boston, MA: Pearson.
- Pender, N.J., Murdaugh, C.L., and Parsons, M.A. (2011). *Health Promotion in Nursing Practice (6th Edition)*. Boston, M.A: Pearson.
- Pender, N.J., Murdaugh, C.L., and Parsons, M.A. (2011). *Health Promotion in Nursing Practice (6th Edition)*. Boston, M.A: Pearson.

- Pender, N.J., Murdaugh, C.L., and Parsons, M.A.(2011). *Health Promotion in Nursing Practice (6th Edition)*. Boston,M.A: Pearson.
- Pender, N.J., Murdaugh, C.L., and Parsons, M.A.(2011). *Health Promotion in Nursing Practice (6th Edition)*. Boston,M.A: Pearson.
- Pender, N.J., Murdaugh, C.L., and Parsons, M.A.(2011). *Health Promotion in Nursing Practice (6th Edition)*. Boston, M.A: Pearson.
- Peterson, S.J., & Bredow,TS. (2004). *Middle Range Theory, application to Nursing Research*. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins
- PPNI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (1st ed). DPP PPNI.
- PPNI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2018). Standart Intervensi Keperawatan Indonesia : Defenisi dan Tindakan Keperawatan (1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2018). Standart Intervensi Keperawatan Indonesia : Defenisi dan Tindakan Keperawatan (1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2018). Standart Intervensi Keperawatan Indonesia : Defenisi dan Tindakan Keperawatan (1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2018). Standart Intervensi Keperawatan Indonesia : Defenisi dan Tindakan Keperawatan (1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2018). Standart Intervensi Keperawatan Indonesia: Defenisi dan Tindakan Keperawatan (1st ed.). DPP PPNI.

- PPNI. (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia. DPP PPNI.
- PPNI. (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia. DPP PPNI.
- PPNI. (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia. DPP PPNI.
- PPNI. (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia. DPP PPNI.
- PPNI. (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia. DPP PPNI.
- Rachel G., Johanna M and Fiona J (2008). Self efficacy measurement and goal attainment after pulmonary rehabilitation. *International Journal of COPD*, 3 (4) 791-796.
- Rachmat S. (2012). *Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2011*, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Direktorat Pelaporan dan Statistik, Jakarta
- Ralf S. (2008). *Modeling Health Behavior Change: how to Predict and Modify the Adoption and Maintenance of Health Behaviors*. The International Association of Applied Psychology: An International Review, 57(1), 1-29.
- Redmond, B.F. (2010). Self Efficacy Theory: Do I think that I can succeed in work? Work attitudes and motivation. Pennsylvania State University Website; <http://cms.psu.edu>. Retrieved January, 2022.
- Riasmini, M. N., Permatasari, H., Chairani, R., & Handayani, W. T. (2017). *Panduan Asuhan Keperawatan Individu, Keluarga, Kelompok, dan Komunitas*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Robinson, J.R. (1994). *Community Development in Perspective*. Ames: Iowa State University Press.
- Rodrigo T, Cayla JA. (2012). *A Predictive scoring instrument for tuberculosis lost to follow-up outcome*. Respiratory Research, <http://respiratory-research.com/13/1/75>. Halaman 1-9.
- Ryan R.M. and Deci E.L. (2006). Self regulation and the problem of human autonomy: Does psychology need choice, self-

determination, and will?. *Journal of personality* 74:6,pp 1557 – 1585.

Serene O, Kimberly E.H. (2009). *The application of behavior change theory to family based services: improving parent empowerment in children's mental health*, NIH Public Access.

Setiadi, (2008). *Konsep & proses keperawatan keluarga*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Shearer. NBC. (2009). *Health Empowerment Theory as a Guide for Practice*, NIH Public Access.

Shearer. NBC. (2010). *Randomized Control Trial of The Health Empowerment Intervention : Feasibility and Impact*, NIH Public Access.

Shin Y., Yun S., Pender N. J., and Jang H. (2005) *Test of the Health Promotion Model as a Causal Model of Commitment to a Plan for Exercise Among Korean Adults With Chronic Disease*. *Research in Nursing & Health*; 28, 117-125.

Sorensen K, Broucke SV, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, and Brand H. (2012). Health Literacy and Public Health: A systematic review and integration of definitions and models. *BMC Public Health* 1 - 13, <http://biomedcentral.com/1471-2458/12/80>, sitasi 3 April 2023.

Sorensen K, Broucke SV, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, and Brand H. (2012). Health Literacy and Public Health: A systematic review and integration of definitions and models. *BMC Public Health* 1 - 13, <http://biomedcentral.com/1471-2458/12/80>, sitasi 3 April 2023.

Sorensen K, Broucke SV, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, and Brand H. (2012). Health Literacy and Public Health: A systematic review and integration of definitions and

- models. *BMC Public Health* 1 - 13, <http://biomedcentral.com/1471-2458/12/80>, sitasi 3 April 2023.
- Sorensen K, Broucke SV, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, and Brand H. (2012). Health Literacy and Public Health: A systematic review and integration of definitions and models. *BMC Public Health* 1 - 13, <http://biomedcentral.com/1471-2458/12/80>, sitasi 3 April 2023.
- Sorensen K, Broucke SV, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, and Brand H. (2012). Health Literacy and Public Health: A systematic review and integration of definitions and models. *BMC Public Health* 1 - 13, <http://biomedcentral.com/1471-2458/12/80>, sitasi 3 April 2023.
- Sorensen K, Stapleton G, Back Peter S. (2013). Exploring the ethical scope of health literacy – a critical literatur review. *Albanian Medical Journal* 2, pages 71-83.
- Sorensen K, Stapleton G, Back Peter S.(2013). Exploring the ethical scope of health literacy – a critical literatur review. *Albanian Medical Journal* 2, pages 71-83.
- Sorensen K, Stapleton G, Back Peter S.(2013). Exploring the ethical scope of health literacy – a critical literatur review. *Albanian Medical Journal* 2, pages 71-83.
- Sorensen K, Stapleton G, Back Peter S.(2013). Exploring the ethical scope of health literacy – a critical literatur review. *Albanian Medical Journal* 2, pages 71-83.
- Sorensen K, Stapleton G, Back Peter S.(2013). Exploring the ethical scope of health literacy – a critical literatur review. *Albanian Medical Journal* 2, pages 71-83.
- Sulistiyani, A.T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* edisi 1, Yogyakarta. Gava Media.

- Sumodiningrat, G. (2000). *Pemberdayaan masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyanto dan Djohan. (2011). *Metodologi Riset Bisnis dan Kesehatan*. Kalimantan: PT.Grafika Wangi.
- Susanne B, Megan M. (2012). *Australian Health Promotion Practitioners Perceptions on evaluation of empowerment and participation*, Health Promotion International journal Published by Oxford University Press, doi: 10.1093/heapro/das046, 1-11halaman, downloaded from <http://heapro.oxfordjournals.org/>, 19 Nov 2023.
- Syamikar, Henny P, Utami R, et.al. (2024). Optimizing Tuberculosis Care through Family Based Nursing Care: A Case Study Approach. *Journal of Pubnursing Sciences*, Vol. 02 No. 1: Hal 1-9.
- Syamikar, Henny P, Utami R, et.al. (2024). Optimizing Tuberculosis Care through Family Based Nursing Care: A Case Study Approach. *Journal of Pubnursing Sciences*, Vol. 02 No. 1: Hal 1-9.
- Syamikar, Henny P, Utami R, et.al. (2024). Optimizing Tuberculosis Care through Family Based Nursing Care: A Case Study Approach. *Journal of Pubnursing Sciences*, Vol. 02 No. 1: Hal 1-9.
- Syamikar, Henny P, Utami R, et.al. (2024). Optimizing Tuberculosis Care through Family Based Nursing Care: A Case Study Approach. *Journal of Pubnursing Sciences*, Vol. 02 No. 1: Hal 1-9.
- Taymoori P, Rhodes R.E, Berry TR. (2010). Application of Social Cognitive Model in Explaining Physical Activity in Iranian Female Adolescent. *Health Educ Res*, vol.25.no.2, pages 257 – 267.

- Volmink J, Garner P. (2009). *Directly observed therapy for treating tuberculosis (review)*. The Cochrane Collaboration, Published by John Wiley & Sons, Ltd. <http://www.thecochranelibrary.com>. diakses tgl 7 Des 2023.
- WHO. (2010). *Treatment of Tuberculosis Guidelines fourth edition*. WHO Library Cataloguing in Publication Data. France.
- WHO. (2012). *Health Education: Theoretical Concepts, Effective Strategies and Core Competencies*. WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean, Cairo.
- WHO. (2016). *On The Road To Ending TB*. WHO Library Cataloguing in Publication Data. France.
- WHO. (2023). *Global Tuberculosis Report 2023*. WHO Library Cataloguing in Publication Data. France.
- WHO. (2023). *Global Tuberculosis Report 2023*. WHO Library Cataloguing in Publication Data. France.
- WHO. (2023). *Global Tuberculosis Report 2023*. WHO Library Cataloguing in Publication Data. France.
- WHO. (2023). *Global Tuberculosis Report 2023*. WHO Library Cataloguing in Publication Data. France.
- WHO. (2023). *Global Tuberculosis Report 2023*. WHO Library Cataloguing in Publication Data. France.
- WHO. (2023). *Global Tuberculosis Report 2023*. WHO Library Cataloguing in Publication Data. France.
- WHO. (2023). *Global Tuberculosis Report 2023*. WHO Library Cataloguing in Publication Data. France.
- WHO. (2023). *Global Tuberculosis Report 2023*. WHO Library Cataloguing in Publication Data. France.
- Williams, G.C. (2002). Improving patient's health through supporting the autonomy of patients and providers. In E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds.), *Handbook of self-determination research* (pp. 233–254). Rochester, NY: University of Rochester Press.

- Wytske W.G, Irene MV.G. (2013). *Barriers, facilitators and attitude influencing health promotion activities in general practice: an explorative pilot study*, BMC family practice, <http://www.biomedcentral.com/147-2296/14/20>.
- Xianqin A, Ke Men, (2010). *Factors associated with low cure rate of tuberculosis in remote poor area of shaanxi province, china: a case control study*, BMC Public Health, <http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/112>, pp. 1-8.

GLOSARIUM

A

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS): kondisi di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah dan tidak dapat melawan infeksi, bakteri, dan kanker.

B

Bakterisidal: mekanisme kerja antibiotik dalam mengatasi infeksi bakteri dengan membunuh bakteri

Bakteriostatik: mekanisme kerja antibiotik dalam mengatasi infeksi bakteri dengan menghambat pertumbuhan bakteri

Basil Tahan Asam (BTA): adalah bakteri penyebab tuberkulosis (TBC) Bakteri ini bersifat tahan asam karena dinding selnya yang kompleks dan mengandung lapisan lemak yang cukup tinggi.

D

Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS): strategi untuk mendeteksi dan menyembuhkan penyakit tuberkulosis (TB).

Diabetes Mellitus: penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi.

E

Epidemi: suatu penyakit telah menyebar dengan cepat ke wilayah atau negara tertentu dan mulai mempengaruhi populasi penduduk di wilayah atau negara tersebut.

H

Human immunodeficiency virus (HIV): virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh.

Hipertensi: kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi.

K

Katastropik: penyakit yang mengancam nyawa, membutuhkan biaya pengobatan yang besar, dan memiliki komplikasi yang serius.

Komprehensif: luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal.

L

Literasi: kemampuan untuk membaca, menulis, dan berbicara, serta mengolah informasi dan pengetahuan untuk kehidupan sehari-hari.

Literasi Kesehatan: kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan.

M

Morbiditas: angka kesakitan atau kondisi seseorang yang sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari normalnya.

Mortalitas: angka kematian atau jumlah kematian yang terjadi pada suatu populasi atau wilayah.

O

Obat Anti Tuberkulosis (OAT): terdiri dari empat jenis obat utama: isoniazid, rifampisin, pirazinamid, dan etambutol. Pengobatan ini harus dilakukan secara teratur dan tuntas sesuai dengan resep dokter untuk mencegah resistensi obat.

P

Pengawas Menelan Obat (PMO): adalah orang yang bertugas untuk memantau pasien TBC agar minum obat secara teratur dan sukses berobat.

Persister: varian sel bakteri yang tidak aktif, tetapi toleran terhadap antibiotik dan dapat bertahan hidup dalam kondisi stres. Persister dapat tumbuh kembali dalam kondisi yang tepat, dan dapat menyebabkan infeksi kronis, kekambuhan pasca perawatan, dan kegagalan pengobatan antibiotik.

Profilaksis: pencegahan infeksi dengan obat.

Promosi: kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, dan perubahan perilaku pasien.

Promosi Kesehatan: upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui: Pendidikan kesehatan, Intervensi sosial dan lingkungan, Kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

Prevalensi: ukuran yang menunjukkan proporsi populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam periode waktu tertentu.

Public Private Mix (PPM): strategi untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, khususnya untuk penanggulangan tuberkulosis (TBC). PPM melibatkan seluruh fasilitas kesehatan (fasyankes) baik pemerintah maupun swasta dalam satu wilayah, seperti kabupaten atau kota.

R

Regimen pengobatan: mengacu pada rencana terapi yang dipersonalisasi dalam penelitian medis yang mencakup keputusan tentang dosis dan jadwal pengobatan berdasarkan informasi klinis pasien dan catatan medis sebelumnya.

S

Surveilans: kegiatan pengamatan dan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus untuk memperoleh informasi tentang suatu masalah.

T

Tes Cepat Molekuler (TCM): metode pemeriksaan untuk mendiagnosis tuberkulosis (TB) yang menggunakan GeneXpert System. TCM menggunakan sampel dahak, bilasan lambung, atau feses untuk mendeteksi adanya bakteri MTB dan resistensi terhadap rifampisin, salah satu obat anti tuberkulosis.

Tuberkulosis (TBC): penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Bakteri ini dapat menyerang paru-paru, tulang belakang, kulit, otak, kelenjar getah bening, dan jantung.

U

Universal Health Coverage (UHC): sistem jaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan.

PROFIL PENULIS



(Dr. Syamilatul Khariroh, S.Kp., M.Kes)

Lahir di Surabaya, 08 September 1965. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Indonesia tahun 1995. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Universitas Airlangga dan lulus tahun 2002. Pada tahun 2016 menyelesaikan pendidikan S3 Kesmas di Universitas Airlangga. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1990 sebagai pengajar di RS. Islam Surabaya (Unusa), Tahun 2000 – 2006 sebagai pengajar di PSIK – FK Unair (FIK – Unair). Saat ini penulis bekerja di STIKES Hang Tuah Tanjungpinang mengampu mata kuliah keperawatan komunitas, keperawatan keluarga, dan keperawatan gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar nasional dan Internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: khariroh65@gmail.com

PROFIL PENULIS



(Endang Abdullah, S.Kp.,M.Si) Lahir di Karawang, 08 Juni 1966. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia lulus tahun 1997. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Manajemen SDM pada Universitas Batam dan lulus tahun 2009. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1990

Sebagai Perwira Pertama Instruktur Militer TNI AL KODIKAL Surabaya. Menjabat Direktur AKPER (Akademi Keperawatan) Hang Tuah AL di Tanjungpinang (Tahun 2004 – 2007), dan Ketua STIKES Hang Tuah Tanjungpinang (Tahun 2007 – 2014). Tahun 2014 sd saat ini penulis bekerja di STIKES Hang Tuah Tanjungpinang sebagai dosen mengampu mata kuliah keperawatan komunitas, keperawatan keluarga, dan keperawatan dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar Nasional dan Internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: endang.eeng866@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas tentang pentingnya kemandirian keluarga dalam pencegahan penyakit TBC melalui peningkatan perilaku promosi dan literasi kesehatan. Penyakit TBC merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian bila tidak dilakukan perawatan dan pengobatan secara tuntas.

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah penularan dengan melaksanakan fungsi dan tugas kesehatan keluarga.

Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep dasar perilaku promosi kesehatan, literasi kesehatan, serta strategi perawatan dan pencegahan penyakit TBC yang dapat dilakukan oleh keluarga.

Dalam konteks pemberdayaan keluarga, buku ini menekankan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencegahan penyakit TBC. Keluarga bukan hanya sebagai pendukung dalam perawatan pasien TBC, tetapi juga sebagai kunci keberhasilan dalam mencegah terjadinya penularan TBC pada anggota keluarga. Melalui peningkatan perilaku promosi dan literasi kesehatan, keluarga dapat lebih sadar dan aktif dalam mengelola perilaku hidup sehat, mengidentifikasi tanda dan gejala penyakit TBC, dan menjalankan pola hidup yang mendukung kebersihan lingkungan dan kesehatan keluarga.

Buku ini tidak hanya ditujukan pada individu sebagai pembaca, tetapi juga memberikan wawasan kepada para profesional kesehatan, masyarakat, dan organisasi terkait upaya bersama untuk eliminasi penyakit TBC melalui peningkatan perilaku promosi dan literasi kesehatan keluarga.

Buku ini membahas tentang pentingnya kemandirian keluarga dalam pencegahan penyakit TBC melalui peningkatan perilaku promosi dan literasi kesehatan. Penyakit TBC merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian bila tidak dilakukan perawatan dan pengobatan secara tuntas. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah penularan dengan melaksanakan fungsi dan tugas kesehatan keluarga.

Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep dasar perilaku promosi kesehatan, literasi kesehatan, serta strategi perawatan dan pencegahan penyakit TBC yang dapat dilakukan oleh keluarga.

Dalam konteks pemberdayaan keluarga, buku ini menekankan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencegahan penyakit TBC. Keluarga bukan hanya sebagai pendukung dalam perawatan pasien TBC, tetapi juga sebagai kunci keberhasilan dalam mencegah terjadinya penularan TBC pada anggota keluarga. Melalui peningkatan perilaku promosi dan literasi kesehatan, keluarga dapat lebih sadar dan aktif dalam mengelola perilaku hidup sehat, mengidentifikasi tanda dan gejala penyakit TBC, dan menjalankan pola hidup yang mendukung kebersihan lingkungan dan kesehatan keluarga.

Buku ini tidak hanya ditujukan pada individu sebagai pembaca, tetapi juga memberikan wawasan kepada para profesional kesehatan, masyarakat, dan organisasi terkait upaya bersama untuk eliminasi penyakit TBC melalui peningkatan perilaku promosi dan literasi kesehatan keluarga.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

